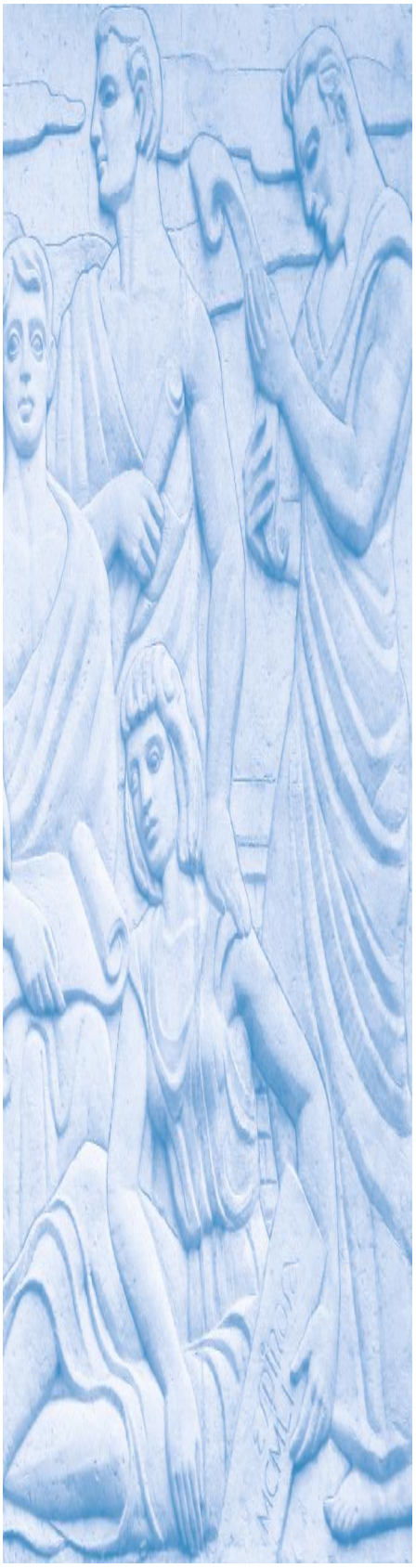


FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ESPECIAL-LOGOPEDIA

MATERIAL DOCENTE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: Manual de orientación a la familia de educandos con disartria

Autor: Lic. Rodisbel González Fonseca.

Tutora: Dr C. Mirian DuanyTimosthe P.T

2023

Pensamiento:

No les evites a tus hijos las dificultades de la vida, enséñales más bien a superarlas.

Louis Pasteur

Agradecimientos:

- En la vida muchas veces recibes ayuda de quien menos lo esperas: agradezco a todo el que de una forma u otra hizo posible que me realizara como profesional.
- A mi esposa y mi hija que han sido mi apoyo incondicional, a mis padres por alentarme siempre a seguir adelante y a mi familia por demostrarme que puedo contar con ellos.
- Agradezco a todo el que puso en mi camino un obstáculo que me hizo crecer y superarme.
- Agradezco a mi tutora por saber enseñarme, por brindarme su apoyo siempre que lo necesite y llame a su puerta, por exigirme y demostrarme con su ejemplo que siempre se puede dar más.

A todos gracias.

Dedicatoria:

Este gran logro va dedicado a mi esposa y a mi hermano por ser mis principales apoyos, a mi hija por ser mi mayor motivación, a mis padres porque gracias a su esfuerzo y dedicación desde que nací hoy puedo estar aquí dándoles ese orgullo tan grande que verdaderamente se merecen y a todos aquellos que me apoyaron de una manera u otra.

SINTESIS

La intervención en la disartria es larga y compleja en este proceso de intervención se ha reconocido el rol que juega la familia para el éxito del trabajo correctivo, para ello necesita de una adecuada preparación, relacionada con las causas que provocan esta patología y su evolución, pero básicamente en su papel en la intervención educativa. La investigación tiene como objetivo proponer un sistema de talleres de orientación familiar para la estimulación del desarrollo psicomotriz de educandos con disartria. La aplicación práctica se concreta en la aplicación de la propuesta, cuyos resultados demuestran que la familia transitó de un bajo nivel de conocimiento a otro superior, cumpliéndose el objetivo propuesto para el cual fue elaborado el manual contentivo de un sistema de talleres y así materializando el objetivo de esta investigación. La familia demostró estar mejor preparada y sensibilizada con el proceso de integración logopeda- familia para la intervención en el proceso de estimulación de la psicomotricidad en el educando con disartria y la contribución a la formación integral de su personalidad y desarrollo pleno, lo que comprueban la validez del presente estudio.

Palabras clave: familia; disartria; orientación familiar; desarrollo psicomotriz.

SYNTHESIS

The intervention in Dysarthria is long and complex. In this intervention process, the role played by the family for the success of the corrective work has been recognized, for which it needs adequate preparation, related to the causes that cause this pathology and its evolution. but basically in its role in educational intervention. The objective of the research is to propose a system of family orientation workshops to stimulate the psychomotor development of students with dysarthria. The practical application is specified in the application of the proposal, whose results show that the family moved from a low level of knowledge to a higher one, fulfilling the proposed objective for which the manual containing a system of workshops was elaborated and thus materializing the objective of this research. The family proved to be better prepared and sensitized with the speech therapist-family integration process for the intervention in the process of stimulation of psychomotricity in the student with dysarthria and the contribution to the integral formation of his personality and full development, which proves the validity of the present study.

Keywords: family; dysarthria; Family counseling; psychomotor development.

INDICE Pág.

INTRODUCCIÓN..... 1

DESARROLLO:..... 5

Epígrafe # 1- Diagnóstico del estado actual de la preparación de la familia en la atención a educandos con disartria. 5

Epígrafe # 2- Marco teórico del proceso de orientación familiar en el contexto de educandos portadores de disartria. 11

2.1.- La orientación familiar como premisa para la preparación de la familia de educandos con disartria. 11

MANUAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR..... 24

2.3. Validación de la pertinencia y factibilidad del manual de Orientación familiar para educandos con disartria. 48

CONCLUSIONES..... 52

RECOMENDACIONES:..... 53

INTRODUCCIÓN

Atender a educandos con disartria da muestra de cuán oportuna es la acción logopédica ante sujetos que han sido afectados con la primera causa de discapacidad de la infancia, con ello se atenúa el impacto sobre la calidad de vida de la persona y su repercusión en la vida familiar y social. La acción temprana sobre las manifestaciones psicomotrices crea las bases para la rehabilitación apropiada y así lograr el máximo desarrollo de los potenciales residuales y su inclusión social.

Los estudios teóricos sobre la disartria parten de considerarla de diferentes formas ya sea como enfermedad o deficiencia, desde donde se valora la necesidad de la rehabilitación eminentemente física y como necesidad educativa especial (NEE) bajo la visión de proveer al sujeto de recursos y ayudas para que pueda avanzar junto a los miembros de su familia y la comunidad.

Es reconocido por diferentes científicos la complejidad del cuadro etiopatogénico de los sujetos con disartria, en el caso específico del lenguaje y la comunicación Moreno, Montero y García –Baamonde (2009) señalan que estas personas presentan entre otros déficits, un gran abanico de dificultades en el ámbito del lenguaje, por lo que es imprescindible dar un tratamiento adecuado desde el contexto educativo.

Abordar la intervención a casos con esta entidad desde el punto médico y no desde presupuestos educativos ha limitado la posibilidad de determinar cómo incidir de manera operativa en la organización adecuada de la respuesta desde la escuela, a pesar de que en los últimos tiempos se trate de abordar la problemática desde una perspectiva global donde se considera la parte educativa como importante.

En el marco educativo es sin dudas el maestro logopeda uno de los principales responsables del desarrollo integral del educando y de la orientación adecuada y oportuna a los agentes educativos que interaccionan con el mismo. Cabe destacar que el papel que va asumiendo la familia a lo largo de la vida del educando con disartria es cada vez más activo. Los padres tienen un rol principal en la atención y cuidado de la persona con discapacidad, los que pueden necesitar apoyos externos para desempeñar sus funciones. Es importante que los padres lleven a cabo las orientaciones y

herramientas otorgadas ya que son los que pasan más tiempo con sus hijos, completando así el trabajo que realiza el maestro logopeda.

En el estudio de la disartria o la Parálisis Cerebral como también es llamada se destacan los resultados de Aguilar (1995), Sancristán (1996), Ruiz de Gauna (1997), Gutiez, Diker y Terigi (1997), Sallán (2001), Martínez (2002), Weiss (2003), Serra (2010), Romera, Iruela (2011), entre otros, los que aportan metodologías, estrategias y sistemas de actividades para el desarrollo integral del educando.

En este proceso de intervención se ha reconocido el rol que juega la familia en el éxito en el trabajo correctivo, para ello la misma necesita de una adecuada preparación relacionada con las causas que provocan esta patología y su evolución, pero básicamente en su papel en la intervención educativa.

La información recopilada y su análisis minucioso permitieron al autor de esta investigación elaborar un manual encaminado a la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de educandos disártricos. Por lo que se pudo constatar la siguiente **situación problémica:** insuficiente atención que brindan los maestros y la familia a los educandos disártricos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, específicamente en lo relacionado con el desarrollo de la motricidad articulatoria. Esta situación limita la efectividad de la labor que realiza el logopeda y con ello la calidad del proceso de atención logopédica que se realiza.

Entre las principales insuficiencias que se detectan se encuentran:

- Dificultades en el cumplimiento de las orientaciones indicadas por el logopeda en el contexto familiar.
- Insuficiente trabajo correctivo- compensatorio en las clases logopédica a los educandos disártricos.
- Poca sistematicidad en la realización de la escuela de orientación familiar para la atención a educandos con disartria.
- Insuficiente conocimiento de la familia sobre esta logopatía verbal, lo cual tiene su repercusión en la insuficiente estimulación desde el contexto familiar que reciben estos educandos.

Los elementos antes expuestos permitieron determinar el siguiente **problema científico:** ¿Cómo contribuir a la preparación de la familia para la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de los educandos con disartria?

Identificando como **objeto:** el proceso de orientación familiar.

Definiendo como **objetivo**: Elaborar un Manual encaminado a la orientación de la familia para la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de educandos disártricos.

Se define como **campo de acción:** La orientación a la familia para la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de educandos disártricos.

Para corroborar la veracidad del problema científico se plantean las siguientes **tareas científicas:**

Diagnóstico del estado actual de la orientación de la familia en la atención a educandos con disartria.

Fundamentación de la propuesta de material docente propuesto.

Valoración de la factibilidad y pertinencia por los especialistas del material docente.

Para cumplimentar las tareas propuestas se emplean como **métodos y técnicas científicas.**

Nivel Teórico:

Análisis – Síntesis: para fundamentar desde el punto de vista teórico el objeto y campo a investigar, analizar y sintetizar la información obtenida con los métodos empíricos, para arribar a conclusiones y recomendaciones.

Inducción –Deducción: para determinar las principales problemáticas e irregularidades y su incidencia en la atención del educando con disartria.

Modelación: para elaborar y estructurar la estrategia que favorezca el desarrollo de la motricidad articulatoria en educandos con disartria.

Sistémico estructural: para establecer los nexos y relaciones de las diferentes partes de la investigación.

Nivel Empírico:

Observación: al logopeda con el objetivo de constatar las orientaciones que realizan con la familia en la atención a educandos disártricos.

- A la familia para corroborar la atención que brindan a los educandos disártricos en el contexto familiar.

Entrevista: Al logopeda con el fin de obtener información sobre la orientación que brinda a la familia de educandos disártricos.

- A la familia para obtener información sobre el nivel de conocimientos que poseen sobre la patología que presentan los educandos y la atención que deben brindar.

Nivel Estadístico Matemático:

Cálculo porcentual: para medir resultados del estado actual y final de la estrategia para el desarrollo de la motricidad articulatoria desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo a través de los diferentes métodos y técnicas aplicadas.

Población y muestra: la población y muestra la conforma 10 familias de educandos en las edades comprendidas de 5 a 10 años portadores de disartria que representan el 100% de educandos con esta patología en la Institución Educativa: Amistad Cuba-Vietnam. Además, se trabajará con los 2 logopedas que trabajan en dicha institución.

Significación práctica: radica en el aporte realizado contentivo de un Manual para la orientación de la familia para la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de educandos disártricos, el mismo se direcciona a dotar las familias de las herramientas necesarias para potenciar la comunicación en estos educandos.

Actualidad: esta investigación se asocia al proyecto de investigación territorial de la Universidad de Oriente que se denomina: Inclusión social y educativa de educandos, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en Santiago de Cuba.

Estructura de la tesis: El presente informe científico consta de: introducción, desarrollo (con dos epígrafes), conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos.

DESARROLLO:

Epígrafe # 1- Diagnóstico del estado actual de la preparación de la familia en la atención a educandos con disartria.

Para la determinación de necesidades de orientación de las familias objeto de investigación, se consideró una muestra intencional teniendo en cuenta el objetivo de la tesis, compuesto por 10 familias de educandos con disartria en las edades comprendidas entre 5 y 10 años que cursan estudios en la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam, correspondientes al 1er y 2do ciclo.

Indicadores para el diagnóstico.

- Nivel de preparación de las familias para la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria en educandos disártricos.

- Métodos empleados por los especialistas para la orientación a la familia de educandos disártricos.

Se utilizaron como métodos: Análisis de documentos: (Ver anexo: 1) con la finalidad de conocer los documentos normativos sobre la orientación de la familia para estimular y desarrollar la motricidad articulatoria en educandos con disartria, así como el trabajo que realizan los logopedas con este fin, sobre la base de lo estipulado.

Documentos analizados:

 Documentos que norman el trabajo dirigido a la atención de los educandos con disartria.

 Expediente logopédico y psicopedagógico.

 Expediente académico.

 Libreta habilitada para la labor social.

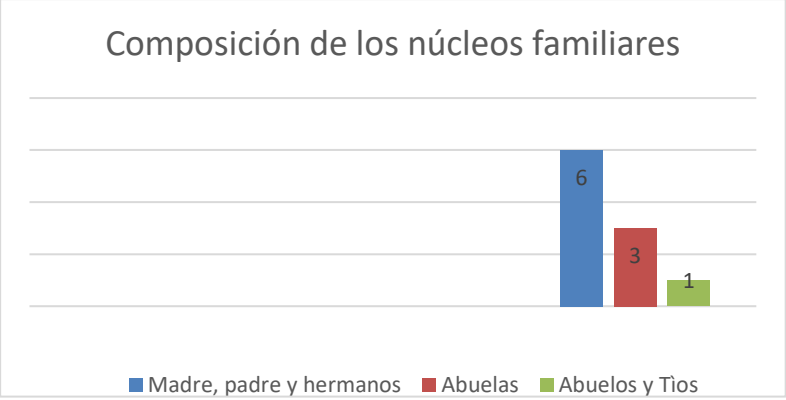


Gráfico # 1. Representación del núcleo familiar de educandos objeto de investigación.

Estas familias se caracterizadas por un bajo nivel económico, en todas prevalece un ambiente hogareño favorable, así como las condiciones de las viviendas en buen estado en 8 de ellas. Se pudo observar que prevalece la sobreprotección hacia los educandos, fundamentalmente en las figuras del padre y abuelos.

Pudimos constatar en los diferentes documentos que aparecen normados el trabajo de la institución en relación con la preparación de los diferentes agentes educativo y entre ellos el trabajo con la familia, con respecto a sus funciones. Sin embargo desde la percepción del autor las limitaciones que presenta el proceso de orientación familiar radican en la no existencia de un diagnóstico que defina las necesidades de orientación y preparación, de estas en cuanto a la atención de las particularidades del cuadro sintomatológico del educando disártricos; lo cual repercute en la limitada atención a las dificultades que estos presentan en la motricidad articulatoria.

En el expediente logopédico se describe el diagnóstico y la estrategia de atención logopédica integral, observándose correspondencia con las necesidades de los educandos en el área del lenguaje y la comunicación, a pesar de esto, no se definen las acciones dirigidas a la orientación de la familia, ni constancia del trabajo sistemático realizado. En el expediente psicopedagógico de igual forma aparece el diagnóstico de los educandos, con mayor énfasis en la discapacidad físico motora y la identificación de la disartria, careciendo de una explicación detallada de las principales potencialidades y necesidades de los educandos, lo cual limita la concepción de una estrategia contextualizada de acuerdo con el cuadro sintomatológico de las áreas afectada. De forma abreviada se pueden encontrar datos relacionados con la familia., sus

particularidades y un análisis de la descripción demográfica de estas, lo cual limita el conocimiento holístico del contexto familiar, su nivel de preparación y conocimientos tan necesarios para la atención de estos educandos.

En el expediente académico se recogen los resultados de aprendizaje y un esbozo sobre la actitud de la familia ante la situación de sus hijos, señalando sus principales necesidades y su vínculo con la escuela, la cual coincide con los criterios observados en estos relacionados con la sobreprotección a sus hijos fundamentalmente en pares y abuelos.

Al revisar la libreta habilitada para la labor social se pudo comprobar que es limitada las visitas a los hogares, lo cual afecta significativamente el proceso ce orientación a las familias. Esta labor social de realizarse sistemáticamente a criterio del autor, contribuiría al perfeccionamiento del trabajo con la familia y hacer más sólidos los conocimientos que debe poseer las familias sobre las particularidades logopédica y psicopedagógica de los educandos disártricos teniendo en cuenta su cuadro sintomatológico primario.

En la observación realizada a las familias (Anexo: 1) se pudo constatar que las familias, están integradas por mamá, papá, abuela, abuelo y tío, caracterizada por un bajo nivel económico, a pesar de esto las condiciones de la vivienda son adecuadas, predomina las familias nucleares (6 para un 60 %), extensas (4 para un 40 %). Se presenciaron actos de amor, respeto y comunicación entre ellos. También pudo constatarse relaciones adecuadas entre los miembros de la familia con los vecinos. Su preocupación por la educación de su hijo no es suficiente, al no existir un nivel de preparación sobre el conocimiento del diagnóstico clínico, logopédico y psicopedagógico que les permita comprender las necesidades de atención que meritan estos casos en todas las áreas de aprendizaje y en particular el lenguaje.

La asistencia a las reuniones, escuelas de orientación familiar, y demás actividades realizadas por el centro y sus especialistas no es sistemática, sin embargo se muestran receptivos a las orientaciones y recomendaciones dadas por la institución, aunque el apoyo al desarrollo integral de su hijo no se realiza adecuadamente, no solo por falta de orientación, sino también porque la falta de interés.

En la entrevista grupal a las familias (Anexo: #3) se parecía escasos conocimientos acerca de las características del lenguaje que presentan los educandos. Las familias no siempre reconocen el papel que pueden jugar para apoyar la estrategia que desarrolla la logopeda y así satisfacer las necesidades de estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria que presentan sus hijos. Tampoco muestran conocimientos sobre los medios que pudieran utilizar en sus hogares para apoyar los tratamientos logopédicos. No tienen dominio de las potencialidades que brindan las actividades cotidianas que realizan dentro y fuera del hogar para satisfacer las necesidades de la adquisición del lenguaje que presentan sus hijos. Por último, se pudo corroborar que la familia se siente poco orientada en qué deben hacer para ayudar a sus hijos, pudiéndose corroborar que las orientaciones que brinda la logopeda no es suficiente, al no planificarse de manera consciente las acciones a realizar por esta con sus hijos, quedando demostrado la necesidad de un diagnostico que permita contextualizar las orientaciones en correspondencia con las necesidades, nivel de conocimiento de las familias y potencialidades para la atención a educandos disártricos.

Prueba proyectiva: (Anexo # 4) Se realizó con el fin de constatar, el nivel de orientación que poseen las familias sobre sus hijos y los recursos que utilizan en función del desarrollo general de estos, también se indagó sobre el conocimiento por parte de la familia de cómo puede apoyar el trabajo del logopeda y que actividades puede realizar para potenciar el desarrollo del lenguaje. Se les dieron a los padres situaciones relacionadas con la propia vida de sus hijos, para que de una forma más amena contaran cómo fue la llegada de su hijo a la familia pero a través de una historia fantasiosa, la aceptación por parte de la familia de un hijo con necesidades educativas especiales en la comunicación y el lenguaje.

Otra situación está relacionada con las actividades que la familia realiza para potenciar la estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria de sus hijos y cómo apoyan el trabajo del logopeda. En general el nivel de orientación que tienen las familias en el análisis de este instrumento es bajo, ya que, demuestran pocos conocimientos acerca del diagnóstico que poseen sus hijos, cómo actuar en cada momento y en particular como estimular el lenguaje y las dificultades que presentan en la motricidad articulatoria. Se pudo observar en los rostros de los padres manifestaciones de tristeza, lo cual evidencia

la aceptación relativa de la discapacidad en sus hijos. Refieren la necesidad de más información sobre la disartria y la atención que pueden brindarle a sus hijos en el hogar, lo cual demuestra la falta de orientación por los especialistas correspondientes a este aspecto en contexto familiar de estos educandos.

En la entrevista realizada al logopeda (Anexo: #3) refiere que los educandos reciben según la frecuencia planificada los tratamientos logopédicos, que han avanzado, pero que aún queda mucho por hacer. Refiere además que los educandos en ocasiones no muestran interés por superar las dificultades en el lenguaje oral. El cuadro sintomatológico que los caracteriza son las inhabilidades para captar las relaciones gramaticales, dificultades en la generalización de los significados, y pobreza de vocabulario activo y pasivo. A pesar de eso se muestran en ocasiones interesados en asistir a los tratamientos logopédico. En la relación logopedia maestro no hay sistematicidad en el seguimiento pedagógico que necesitan estos educandos; siendo este un factor determinante en el trabajo correctivo compensatorios de esta logopatía verbal.

Reconoce la logopeda que existe falta de sistematicidad en el trabajo con la familia a pesar de reconocer el valor de este proceso, fundamentalmente en el qué hacer y qué medios utilizar desde la casa para contribuir al desarrollo del lenguaje, la motricidad fina y articulatoria en sus hijos. Las vías más utilizadas para la orientación a los padres por el logopeda está la visita al hogar y la conversación cuando llevan o recogen a los educandos, sin embargo se carece de un sistema de trabajo para la realización de talleres de orientación familiar y tratar temas de interés por la familia, dejando al libre albedrío las temáticas abordadas en contextos informales.

Las maestras de los grupos muestreados plantean que les falta preparación para trabajar con estos educandos específicamente en lo relacionado con la estimulación del desarrollo del lenguaje, reconoce que son educandos que se diferencian de los demás, con mayores carencias para expresar sus ideas, con pobre desarrollo del vocabulario. Aunque mantiene una buena comunicación con la logopeda no tiene conocimientos suficientes para estimular la motricidad articulatoria desde sus clases, aspecto observado que aún es deficitario.

Reconocen que el trabajo con la familia es muy complejo, a las actividades que se planifican por lo general no asisten muchos padres, en el caso de estos educandos no es sistemática su participación, no aportan sus criterios, no expresan sus preocupaciones, aunque colaboran en alguna medida con las actividades del grupo. La preocupación por el aprendizaje de los educandos es de forma irregular. Las maestras reconocen que ellas no ofrecen recomendaciones específicas a las familias con respecto al papel que les corresponde en el desarrollo y estimulación de la motricidad articulatoria en sus hijos.

Una vez realizado aplicado los diferentes métodos y técnicas para el diagnóstico pudimos definir las fortalezas y necesidades, necesarias para el establecimiento de acciones necesarias para la orientación y preparación de las familias en su desempeño con los educandos disártricos.

Fortalezas:

• Existe un clima afectivo favorable entre los miembros de la familia con los educandos.

• Los miembros de la familia reconocen que no tienen preparación para ayudar en el desarrollo del lenguaje de sus hijos y solicitan ayuda.

• Los miembros de la familia son receptivos a las orientaciones y recomendaciones dadas por la institución, aunque no lo ponen en práctica.

• Los educandos son alegres, les gusta la computación y por lo general no dejan de asistir a la escuela.

Necesidades:

 Bajo nivel cultural de la familia, esto influye en su contribución al desarrollo del lenguaje, aunque manifiestan disposición para ayudar a sus hijos.

 Limitados conocimientos acerca de la ayuda que le pueden ofrecer al educando, así como las actividades que pueden realizar para contribuir al desarrollo del lenguaje.

 Poca sistematicidad familia- logopeda en el logro de una adecuada estimulación y desarrollo de la motricidad articulatoria en los educandos, en correspondencia con sus características.

Lo antes expuesto, nos conduce a proponer como aporte de esta investigación un manual de orientación familiar para desarrollar la motricidad articulatoria en educandos disártricos.

Epígrafe # 2- Marco teórico del proceso de orientación familiar en el contexto de educandos portadores de disartria.

El presente epígrafe tiene como objetivo abordar la fundamentación teórica en torno a la orientación familiar, las contribuciones más importantes sobre este proceso, lo que facilitó adoptar posiciones de este proceso en el contexto de educandos con disartria, teniendo en cuenta las funciones que les competen para la estimulación y desarrollo de la motricidad articularia a partir de las particularidades de esta logopatía verbal. Se aborda con particular énfasis lo relacionado con la orientación y la preparación de la familia como ámbito de acciones educativas.

2.1.- La orientación familiar como premisa para la preparación de la familia de educandos con disartria.

La familia es la célula básica de la sociedad, porque ocupa un lugar principal en el conjunto de influencias educativas ya que constituye la institución que inicia, acompaña y sucede a la educación escolarizada, es donde se comienza la asimilación de la experiencia histórico cultural heredadas de generación en generación, donde la comunicación se convierte en el instrumento más importante para trasmitir sentimientos, pensamientos, costumbres, que más tarde se expresan en la actuación consciente en el medio en que se desarrolla cada uno de sus miembros.

Conducir la preparación de todos los contextos de actuación es una de las funciones esenciales de la escuela como institución cultural y en particular a la familia para que esta asuma su responsabilidad educativa en una dirección más acertada y positiva. Trabajos valiosos entre los que se destacan autores como: Castro (1996), Díaz (2001), Arés (2002), Briña (2007), Duany (2009), Thompson (2010), Mosqueda (2016), Sampayo (2016),Santisteban (2016) y Comendador (2018), exponen la orientación familiar enmarcándose en trabajos de investigación en educandos de diferentes categorías diagnósticas, abordándose temáticas relacionadas con la prevención, estimulación y tratamiento correctivo ante determinadas manifestaciones o desajustes en diferentes

áreas de su desarrollo. Estos investigadores proponen acciones de orientación a la familia como vía de solución de las problemáticas que se presente.

La familia, según Comendador (2018), funciona como marco de referencia de la sociedad, como portadora de la ideología de normas, costumbres que a estas caracterizan y su influencia está estructurada sobre una base marcadamente emocional. Esto nos demuestra la importancia de la familia en el proceso de educación del hombre al que aspira nuestra sociedad; tomando en consideración que de una correcta educación familiar dependerá en gran medida la formación de buenos ciudadanos y a su vez el verdadero valor de la familia dependerá de la calidad de sus miembros, de los sentimientos que los mantienen unidos, de la organización que exista, del nivel cultural, la integración social y los valores morales.

La orientación familiar se define como el proceso de ayuda a la familia con objeto de mejorar su función educativa (Sánchez, 1988) pero también, la dinámica funcional, adaptación a sus circunstancias y al entorno vital. Oliveros (1989) considera que la orientación familiar es un servicio de ayuda para la mejora personal de quienes integran una familia, y para la mejora de la sociedad en y desde las familias, suponiendo un proceso de ayuda a cada familia asesorada que se extiende a todos los miembros cuando también tienen parte de responsabilidad, de ayuda, de educación o de suplencia en la misma.

La orientación familiar, según Romero (1998), puede entenderse como una ayuda prestada a la familia a través de un conjunto de técnicas encaminadas a prevenir y a afrontar dificultades por las que atraviesan sus miembros en los distintos momentos del ciclo vital.

Este autor afirma que las múltiples variables que interactúan en una situación personal se tornan confusas dificultando la orientación personal, profesional y escolar, complejidad que se acrecienta para la orientación familiar.La orientación, a criterio del autor de esta investigación, supone no sólo la simple consulta, sino que es más bien un proceso de acciones y prácticas que se dan en varios momentos y en dirección a una meta principal: ayudar a la persona a tomar conciencia de sí mismo, de los modos en que interacciona y de las influencias que ejerce y padece para poder clarificar sus problemas y las

posibilidades que tiene de superarlos; en esta ocasión vamos a centrarnos en uno de sus ámbitos de aplicación, concretamente, el de la orientación familiar.

Por lo que se asume que la orientación familiar es "un sistema de influencias conscientes pedagógicamente dirigidas a los padres y otros familiares cercanos responsabilizados con la educación de los niños y adolescentes en el hogar, encaminado a elevar su preparación pedagógica y a estimular su participación activa en la formación de su descendencia" (Rodríguez, J, 1990 p. 7), sin dejar de mencionar la orientación familiar como otro aspecto esencial para lograr "...un proceso de ayuda para la mejora personal de quienes integran la familia y para la mejora de la sociedad en y desde la familia, fundamentalmente en todo aquello que hace referencia a la educación familiar". (Casas, G, 1988 p. 25).

En múltiples trabajos se fundamentan desde las ciencias pedagógicas la importancia de la orientación, al enfatizar la labor educativa de la familia como primer mediador y educador del niño. Dentro de los principales representantes se destacan ilustres pedagogos como: J. A Comenius (1592-1670), J.J Rousseau (1712-1778), J. E Peztalozzi (1746-1827) este último refiere que la educación del niño debe comenzar desde el primer día en que veía la luz ya que el momento del nacimiento del niño marca el inicio de su educación, y desarrollo en un ambiente de libertad en el seno familiar, al respecto J. E Pestalozzi refiere que el recién nacido está dotado de todas las facultades humanas pero sin desarrollar, un botón no abierto todavía; por consiguiente es necesario comenzar a educar desde este momento, pero no de cualquier manera sino científicamente.

En los últimos años ha cobrado auge el tema de la orientación familiar, esto ha seguido dos vertientes específicas, por un lado la preparación científica de profesionales, que de una u otra manera, tienen la misión de implementarla. La otra vertiente es la relativa al desarrollo de programas enfocados a la preparación de la familia, o específicamente a los padres y madres, para el mejor desarrollo de su función educativa. Se parte del reconocimiento de que, hoy día la familia ya no puede seguir actuando sólo en orientaciones de carácter intuitivo producto de la costumbre o la experiencia, sino que es posible aspirar a una preparación fundamentada científicamente. Esta idea es la que

toma o deben tomar como base los programas de escuela para padres o los programas dirigidos a los profesionales de la orientación familiar.

Cuando trabajamos con familias necesitamos una visión científica desde el punto de vista filosófico, psicológico, sociológico y pedagógico para evitar visiones subjetivas influidas por nuestra propia experiencia de familia. Este conocimiento puede partir de las diferentes escuelas que nos proporcionarán un marco general para entender cualquier modelo de familia. Sin embargo, aunque no centraremos nuestra atención sobre los distintos enfoques, hemos considerado interesante destacar que diferentes perspectivas intentan aportar elementos para la comprensión de la dinámica de la orientación dentro del contexto y sistema familiar haciendo una breve reseña sobre las principales posiciones y puntos de vistas que sobre la familia existen y que contribuyen a fundamentar científicamente la necesidad de la orientación familiar en contexto de educandos con disartria.

Desde el punto de vista filosófico, se concibe el desarrollo del individuo como un proceso en continuo progreso encaminado a la formación integral del hombre. Los aportes teóricos y metodológicos realizados en este campo por los clásicos del materialismo dialéctico e histórico adquieren una gran significación al presentar a la familia como una categoría histórica que cambia en correspondencia con las transformaciones sociales, que está condicionada por el régimen imperante y por el carácter de las relaciones que en el contexto histórico- social se desarrollan.

Carlos Marx en los Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844, aporta un primer elemento para entender a la familia como la “relación directa, natural y necesaria personas a personas, es la relación del hombre y la mujer. Esta relación natural de los sexos, la relación del hombre con la naturaleza, es inmediata”

Por otra parte Federico Engels en su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” (1891) plantea que la forma más antigua y primitiva de la familia es el matrimonio y demostró con los datos de su época, que esta es una categoría histórica y que por tanto cambia de acuerdo con las transformaciones sociales, en cuyo contexto hay que estudiarla y comprenderla. Para el autor la relación sociedad familia no es unidireccional, expresa que: “El orden social en que viven los hombres en una época, en

un país dado, está condicionada por esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, por una parte y de la familia, de otra" (p. 7).

La familia como objeto de investigación psicosocial ha sido analizada por la Psicología y la Sociología, siendo divulgada en nuestro país por los investigadores del Centro de Investigaciones Psicológicas y Pedagógicas de la Academia de Ciencias de Cuba (CISP, 1990)

Desde los presupuestos psicológicos, se coincide con Vigotsky y sus postulados sobre el enfoque histórico cultural lo cual constituyen los fundamentos de la investigación, no sólo por su teoría marxista, materialista dialéctica, para comprender al mundo, al hombre y al proceso de su desarrollo en su interacción con la realidad socio-histórica en la que está inmerso, sino, por lo pertinente profundo y vigente que resultan sus concepciones acerca del aprendizaje como proceso de apropiación de la experiencia histórico social. Además, su sustento se encuentra en la suspensión del carácter interactivo del desarrollo humano y muy especialmente del llamado determinismo social del desarrollo psíquico, desde cuyas perspectivas se reconoce la extraordinaria importancia de la acción intencional y debidamente organizada de la enseñanza como fuente que conduce al desarrollo, como fruto de la interacción social con otras personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la cultura, dichas interacciones tienen un carácter educativo implícito o explícito y pueden producirse en diferentes contextos tales como la familia, los grupos sociales y otros agentes educativos que influyen en desarrollo de la personalidad del educando y en particular de los que se encuentran en situación de discapacidad y en particular los educandos disártricos.

La psicología como ciencia ofrece métodos, técnicas y procedimientos para la profundización en categorías como: situación social del desarrollo, zona de desarrollo próximo, entre otras, las que permiten la caracterización e intervención para la estimulación del desarrollo de la personalidad como base de la atención logopédica integral del educando con disartria.

Aprender, según Castellanos y otros (2004), supone el tránsito de lo externo a lo interno, es decir de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, de la dependencia a la independencia, de la regulación externa a la autorregulación, de modo que es un proceso que se

caracteriza tanto por su carácter intelectual como emocional, implicando a la personalidad como un todo y aunque su centro lo constituye el propio sujeto no desconoce la participación, la colaboración, la comunicación y la interacción con otros sujetos.

El manual propuesto toma en consideración que el aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico, de apropiación individual de la experiencia social y multidimensional por sus contenidos, mecanismos y condiciones. Los contenidos previstos para la orientación a la familia de educandos con disartria responden a las particularidades psicológicas, sociológicas y pedagógicas de estos educandos, el cuadro sintomatológico de esta logopatía verbal, así como las necesidades, motivos e intereses concretos de las familias.

En este sentido se asumen los fundamentos pedagógicos de la orientación familiar de autores cubanos (Castro, 2005; Ares, 1990; Suárez 1999; Del Pino y Recarey, (2004), que ofrecen una visión holística de este proceso, su carácter significativo y valor formativo. Estos autores reconocen que la orientación familiar es un proceso que debe ser desarrollado por docentes como agentes de cambio mediante su labor de asesoría educativa con la familia.

En el afán de satisfacer las expectativas que la sociedad demanda de la escuela como institución educativa, es que cada vez más esta debe convertirse en el centro a partir del cual emanen las mejores influencias para los niños, adolescentes y jóvenes que se forman en la comunidad a la que pertenece la escuela.

Cuando un educando con disartria se incorpora a una institución educativa necesita de la atención de un adulto que le enseñe cómo activar aquellas estructuras de conocimiento que son indispensables para el desarrollo integral. Es en esta interacción que surgen las necesidades educativas especiales, pues ellas implican la dotación de medios especiales de acceso al currículum mediante un equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del medio físico o unas técnicas de enseñanza especializadas, la dotación de un currículum especial o modificado y una particular estructura social y el clima emocional en los que tiene lugar la educación, proceso en que el logopeda juega un papel de crucial importancia.

Los fundamentos sociológicos parten del condicionamiento social de la educación, por lo que la familia como institución social, responden al encargo a ella asignada. La

concepción de la formación integral del educando toma en cuenta este encargo social y su necesaria socialización entre todos los agentes que intervienen en su educación y en particular su contexto familiar, para que puedan apropiarse de las influencia que estas ejercen sobre el educando, expresados en formas de conducta aceptadas por la sociedad, al tiempo que los interioriza.

En principio debemos reconocer el papel de la familia como institución social y la necesidad de la orientación familiar en su preparación en el ejercicio de sus funciones, por lo que el accionar de la escuela no puede conducirnos a una consideración mecanicista en este proceso. En efecto, el sujeto procedente de un medio familiar desfavorable no tiene necesariamente que reproducir conductas negativas, como también sobran ejemplos de sujetos procedentes de medios familiares muy favorables que asumen conductas socialmente rechazables.

Podemos suponer que lo verdaderamente importante no es el medio familiar en sí mismo, sino la educación que se recibe dentro de él; es esta influencia educativa la que asume una significación valedera para el resto de la vida, aun cuando puede sufrir importantes modificaciones a lo largo de la experiencia vital del sujeto y su inserción en los diversos contextos sociales. La propuesta del Manual de orientación a la familia asume la educación como un fenómeno determinado socialmente, que a su vez es determinante por su estrecha relación dialéctica con el Estado, y los presupuestos del código de la familia vigente que dentro de sus objetivos principales es de contribuir al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíprocos entre sus integrantes; de igual forma al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la protección, formación moral y educación de los hijos para que se desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista; además, a la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos, lo cual refrenda los postulados de la Educación Especial.

La disartria es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la psicomotricidad del sujeto. Por consenso internacional, se propone como definición: “La disartria describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo del feto o el educando.

Los desórdenes psicomotrices de la disartria están a menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento".

La disartria es, un trastorno neuromotor, que se manifiesta con una tríada de síntomas principales (alteraciones del tono muscular, la postura y el movimiento). Estas manifestaciones pueden ir acompañadas de distintos síntomas asociados: de la cognición (déficit intelectual), de la comunicación (dificultades en la articulación de las palabras), crisis convulsivas (epilepsia) y sensoriales.

En todo caso, para poder diagnosticar la disartria, deben estar presentes, al menos, cuatro de los siguientes síntomas. Levin HS, Hamsher KS, Benton AL, (1987)

1. Patrones anormales en la postura y el movimiento.

2. Patrones anormales en el movimiento que controla la articulación de las palabras.

3. Estrabismo.

4**.** Alteración en el tono muscular.

5. Alteración en el inicio y evolución de las reacciones posturales.

6. Alteración en los reflejos.

La incidencia de esta condición en países desarrollados es de aproximadamente 2 – 2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a pesar de los avances médicos como la monitorización de las constantes vitales de los fetos. La disartria no tiene cura conocida; la intervención médica aparece como una ayuda. Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su vida diaria hasta su muerte.

Las causas que producen la disartria van a depender y a variar de un caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque todos desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del sistema nervioso central. La disartria puede producirse tanto en el período prenatal, perinatal o postnatal, teniendo el límite de manifestación transcurridos los cinco primeros años de vida.

En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y pueden influir las condiciones desfavorables de la madre en la gestación. Suele ocasionar el 35% de los casos. Los factores prenatales que se han relacionado son las infecciones maternas (sobre todo la rubéola), la radiación, la anoxia (déficit de oxígeno), la toxemia y la diabetes materna.

En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del parto. Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, y en general, todo parto que ocasiona sufrimiento al educando.

En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades ocasionadas después del nacimiento. Corresponde a un 10% de los casos y puede ser debida a traumatismo craneal, infecciones, accidentes vasculares, accidentes anestésicos, deshidrataciones, entre otras.

Para su diagnóstico y tratamiento se establecen distintas clasificaciones basándose en diferentes criterios como por ejemplo:

Efectos funcionales: referido al lugar donde se localice la lesión cerebral, estas se clasifican en:

 Espástico: este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir, notable rigidez de movimientos, incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la corteza cerebral que afecta los centros motores. Los síntomas más frecuentes son: hipertonía, hiperreflexia e hiperflexión. La lesión está localizada en el haz piramidal.

 Atetósico: en esta situación, la persona presenta frecuentes movimientos involuntarios que interfieren con los movimientos normales del cuerpo. Se producen por lo común, movimientos de contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar. Las afecciones en la audición son bastante comunes en este grupo, que interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios basales del cerebro parece ser la causa de esta condición. Menos del 10% de las personas con disartria muestran atetosis. La lesión está localizada en el haz extrapiramidal.

 Atáxico: en esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal, una marcha insegura y dificultades en la coordinación y control de las manos y de los ojos. La lesión del cerebelo es la causa de este tipo de disartria, relativamente rara.

 Formas mixtas: es raro encontrar casos puros de espasticidad, de atetosis o de ataxia. Lo frecuente es que se presente una combinación de ellas.

Clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral: Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de topografía, que indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre:

 Hemiplejia: afecta a uno de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo).

 Cuadriplejia: los cuatro miembros están paralizados.

 Paraplejia: afectación de los miembros inferiores.

 Monoplejia: un único miembro, superior o inferior, afectado.

 Triplejia: tres miembros afectados.

 Hemiparesia faciobraquial crural: Afectada la cara, un brazo y una pierna

No todas estas manifestaciones del trastorno tienen que darse en todos los casos, ni de forma simultánea.

En educandos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a una disartria debemos tener en cuenta que hay que conocer las características del desarrollo individual, cuadro sintomatológico, los cuales resultan indispensables en la atención a las diferencias individuales.

De la objetividad y la precisión en el diagnóstico dependen, en gran medida, la estructuración de las ayudas a los educandos y a sus familiares. Es por ello que se debe tener claro, cómo se estructura la personalidad de los sujetos con esta entidad, de qué factores depende su desarrollo, que métodos favorecen su desarrollo, que técnicas y procedimientos se debe emplear en cada caso, qué sistemas alternativos o aumentativos de comunicación requieren.

La heterogeneidad de las personas diagnosticadas con disartria es inmensa ya que, además del subtipo de discapacidad y la comorbilidad asociada; se ven influenciados por

aspectos como la detección precoz, la atención temprana, el uso de ayudas técnicas, la motivación, por lo que cada individuo evoluciona de forma diferente y manifiesta un desarrollo propio presentando una serie de alteraciones en el mismo.

Estas alteraciones son derivadas de forma directa o indirecta de su trastorno neuromotor. Esta premisa se basa en que la mayor parte de las habilidades que se adquieren tienen un componente motor (ya sea andar, manipular, hablar, escribir). Dichas habilidades se pueden adquirir en diferente grado, más o menos alteradas o incluso no llegar nunca a lograrse. Todo ello, junto con las posibilidades de vivir experiencias enriquecedoras y el uso de ayudas técnicas, condicionan la forma de entender e interactuar en el mundo que les rodea y así mismo y cómo su entorno y la sociedad en general les percibe y se relacionan con ellos.

Es necesario conocer los aspectos diferenciales de su desarrollo, ya que son éstos los que van a generar las necesidades especiales, sin olvidar la individualidad de cada uno: Desarrollo cognitivo: en los casos en los que el educando no tiene ningún trastorno asociado a su desarrollo cognitivo, el desarrollo evolucionará siguiendo las mismas pautas, pero con diferentes grados de retraso madurativo debido al atraso en la comunicación, dificultades motrices y factores afectivos. Los datos recogidos de la Asociación de Disartria de Navarra (ASPACE) en el 50% de los casos presentan discapacidad intelectual. En el 39% de los casos la discapacidad intelectual es de nivel severo.

En el desarrollo lingüístico generalmente las personas con grave afectación no hablarán o lo harán con mucha dificultad pero, si entenderá el lenguaje oral y la información del exterior. Los problemas más característicos del lenguaje son: disartria (trastorno motor que afecta a la expresión del lenguaje), apraxia o dispraxia (alterado el movimiento voluntario) y retraso leve o grave del lenguaje (retraso generalizado del desarrollo).

Algunos educandos con disartria presentan problemas de babeo o sialorrea (excesiva salivación), en la deglución y masticación y en la respiración que influyen en el desarrollo lingüístico y en las relaciones sociales. El desarrollo motor de los educandos con disartria se caracteriza por un retraso motor que se manifiesta en los mecanismos de: Equilibrio postural y la persistencia de reflejos anormales. La existencia de trastornos motores

específicos como sincinesias (no hay independencia segmentaria), paratonías (contracciones involuntarias), apraxias (dificultad para comenzar movimientos voluntarios), ataxia (falta de coordinación muscular) y rigidez basal (no hay relajación muscular en reposo)

En el desarrollo socio-afectivo se aprecia dificultad para asimilar los cambios en el medio lo que conlleva a la frustración y a la desmotivación de la persona, pudiendo llegar a la indefensión y pasividad aprendida y carecer de expectativas de autoeficacia. Desde ASPACE se habla incluso de una serie de trastornos emocionales: “ya que el trastorno motor produce una mala adaptación al entorno social, un aislamiento, estigmatización social aumentando así las probabilidades de desarrollar trastornos psicológicos y emocionales, trastornos del humor (depresión, vulnerabilidad en la adolescencia), ansiedad, hiperemotividad, inmadurez afectiva (discordancia entre la evolución afectiva y el nivel intelectual)”.

Las necesidades educativas especiales derivadas de la disartria afectarán a los ámbitos de postura, movilidad y desplazamiento; manipulación, comunicación y lenguaje, sensorio-perceptivo, afectivo-social, autonomía personal así como a los aprendizajes escolares propiamente dichos**.**

1. Necesidades relativas a la postura, movilidad y desplazamiento: Es frecuente que presenten problemas en sus desplazamientos por ausencia o inestabilidad en la marcha, por lo que suelen necesitar diferentes ayudas técnicas (sillas de ruedas, muletas, andadores), también muestran dificultades para mantener una postura adecuada y para adaptar las distintas partes del cuerpo a los cambios posturales haciendo necesario la adaptación del mobiliario escolar y personal específico como cuidador y fisioterapeuta.

2. Necesidades referidas a la manipulación: la ausencia de control postural, la incoordinación de movimientos y las dificultades para la independencia segmentaria repercuten en la utilización de los miembros superiores. Es preciso adaptar el material didáctico de manera que se facilite la realización de las tareas.

3. Necesidades asociadas a la comunicación: en algunos casos, puede haber dificultades en la expresión oral y/o escrita, e incluso incapacidad para exponer sus deseos a través de expresiones faciales o gestos. Es imprescindible el uso de ayudas técnicas, SAAC

(Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de la Comunicación), así como la intervención educativa no sólo en el desarrollo del habla, sino en todos los procesos comunicativos.

4. Necesidades sensorio-perceptivas: pueden presentar pérdidas o disminución de la audición y de la visión. De igual forma, las alteraciones cenestésicas más relevantes condicionan la adquisición e integración del esquema corporal y la estructuración espacial y temporal. Por lo tanto, requieren intervención específica por parte de especialistas y ayudas técnicas.

5. Necesidades afectivo-sociales: la incapacidad de influir eficazmente sobre su entorno, conlleva la ausencia de control de cualquier experiencia personal, generando sentimientos de incompetencia y debilitando la motivación de logro. Es necesario reforzar la motivación para el trabajo escolar y diseñar actividades y estrategias que generen sentimientos de autoeficacia y normalización de las interacciones sociales. Propuesta de intervención con un alumno con disartria. Una mirada inclusiva.

6. Necesidades relativas a la autonomía personal: las alteraciones de movilidad y control postural condicionan el desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria dificultando la adquisición de la autonomía personal. Es primordial desarrollar un programa de autonomía individual, proporcionando los recursos materiales y personales necesarios.

7. Necesidades relativas a los aprendizajes escolares: aunque no tiene por qué verse afectada su capacidad intelectual aparecen, en la mayoría de los alumnos, problemas de aprendizaje derivados fundamentalmente de su limitado contacto y control sobre el mundo que les rodea. Por ello, requieren adaptaciones curriculares para acceder de forma exitosa al proceso de enseñanza- aprendizaje.

Los argumentos antes expuestos nos conducen a concebir acciones para orientar a las familias de educandos con disartria en aspecto relacionados con sus características esenciales para tomar decisiones sabias que repercutan favorablemente en su dinámica funcional y para que también ejerzan el control sistemático, consecutivo y regulador, con la consiguiente satisfacción de las necesidades de orientación que siempre tienen las personas y en particular las familias de educandos en situación de discapacidad del lenguaje y la comunicación.

MANUAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR



Índice Pág.

Introducción	1	
¿Que nos motiva a realizar este manual?	3	
Contenidos del manual	3	
Organización y conducción de las sesiones de trabajo con los padres	3	
Preparación y características del logopeda	4	
Actitudes y habilidades del logopeda	5	
Estructura, organización y funcionamiento del manual de orientación a la familia de educandos con disartria	6	
Propuesta de talleres para la orientación a familias de educandos con disartria	7	
Momentos en los que se realiza los talleres	9	
Talleres de orientación familiar para el desarrollo de la motricidad articulatoria a educandos con disartria	10	
Taller # 1 Conociendo a mi hijo portador de disartria.	10	
Taller # 2 La relajación corporal en el educando disártrico	11	
Taller # 3 ¿Cómo desarrollar la motricidad gruesa y el equilibrio a través del baile?	12	
Taller # 4 El desarrollo de la motricidad articulatoria en los niños disartricos	13	13
Taller # 5 ¡Vamos a jugar!	14	
Taller # 6 ¿Cómo fortalecer el equilibrio y la fuerza**?**	15	
Taller # 7 Diferentes vías de comunicación (SAAC)	16	
Taller #8 Estimulación de los órganos articulatorios del niño con disartria	17	
Taller # 9 Cómo involucro a mi hijo en las actividades cotidiana en el hogar	18	
Taller # 10 Mis derecho y deberes en el contexto social	19	

Introducción

Lograr una convivencia familiar armónica, estable de vida, en nuestro país, en los momentos actuales resulta bastante complejo en tanto que las condiciones económicas, de algunos hombres, y a la falta de fe en el cambio en otros, han dañado la espiritualidad en muchos miembros de la sociedad incidiendo esto en la familia cubana.

La familia cubana transita hoy por un proceso de cambio y transformaciones en su estructura y dinámica sobre lo cual incide un conjunto de dificultades que influyen en el cumplimiento de sus funciones familiares y a su armónico desenvolvimiento. De ahí que nuestro país, y en particular el sistema educacional trabaje con la familia para que esta pueda ejercer satisfactoriamente su labor educativa.

A través de la orientación familiar se ofrecen alternativas que permiten lograr una mejor convivencia en el hogar y promover un modo de vida más sano y culto, una vez que sus miembros se impliquen en la formación y preparación de sus hijos.

En el desempeño de su función educativa, el logopeda debe de ayudar a la familia en el ejercicio de su responsabilidad, porque al ser la escuela el centro cultural más importante de la comunidad, el educador se convierte en uno de los profesionales mejores preparados para esta labor, siendo a su vez el comunicador social por excelencia que puede armar de conocimientos a otros agentes socializadores para el desempeño educativo.

Cuando trabajamos juntos y de forma cohesionada con la familia del educando, se puede alcanzar el objetivo principal de educar a las nuevas generaciones, en un pensar, sentir y actuar coherentes y lograr la autodeterminación del individuo como personalidad.

El fin social de la educación familiar consiste en posibilitarles a los padres una adecuada orientación pedagógica, de manera que le permita participar de forma activa y consciente en la educación de sus hijos.

La influencia de la familia en el educando tiene bases históricas. Sin embargo, han sido pocos los que se han plateado la pregunta: ¿Es importante que los padres reciban una preparación especial para la atención y crianza de sus hijos?

Un por ciento elevado de educandos presentan algún tipo de discapacidad, lo que origina un impacto en el hogar, trayendo como consecuencia que se rompan todas las expectativas que sobre estos se habían formado, la familia se siente desorientada y desconoce que hacer para ayudar al educando en su desarrollo. Por lo que la mejor forma de preparar a los padres para el cumplimiento de sus funciones es a través de la orientación que recibirá en las diferentes instituciones, pero específicamente desde la escuela que es la encargada de su preparación para su desempeño educativo.

Presionados por influencias originadas por cambios sociales; muchos padres no saben cómo actuar en la atención de sus hijos portadores de disartria. En ocasiones el agravamiento del cuadro sintomatológico de esta patología origina que los padres que los padres se muestren desorientados en cómo actuar ante esta circunstancia y cómo favorecer la formación y desarrollo de la personalidad de los hijos, por lo que es necesario prepararlos para el ejercicio de sus funciones.

En este empeño consideramos importante la puesta en práctica de un manual de orientación familiar, que tenga en cuenta los siguientes **principios**:

- Necesidad de respeto al sujeto de orientación:

Debemos tener en cuenta que en el trabajo con los padres se respeten sus criterios y puntos de vistas; no debemos imponerles normas, reglas, ni invadir su vida familiar con el objetivo de modificar su conducta, o establecer nuevos patrones, sino, sugerirles alternativas educativas para que sean más eficaces en la satisfacción de las necesidades educativas de los hijos.

- Necesidad de la integración de las influencias educativas de la triada familia-escuela-comunidad:

Se basa en que para el ejercicio de esta labor no basta con el funcionamiento separado de estos eslabones, sino en su integración total donde de forma interrelacionada se tributen y puedan ejercer su influencia educativa.

- Principio de la escuela como institución social integradora de la triada familia-escuela-comunidad:

La tarea de orientación a la familia compete a diferentes instituciones sociales, pero especialmente a la escuela, ya que están demostradas las potencialidades de esta y de su personal docente, para llevar adelante las transformaciones en el sistema familiar.

- Principio del diagnóstico de orientación familiar:

Para que la orientación familiar sea efectiva debe diagnosticar las necesidades de las familias, esto nos permitirá que las acciones que orientemos en el trabajo con ellas sean efectivas.

- Principio de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo:

Este principio como expresión más importante de la enseñanza pues condice al desarrollo, es importante tenerlo en cuenta en el trabajo con la familia, ya que los padres deben crearle todas las condiciones a los hijos para que desarrollen todas sus potencialidades y ellos estimularlos al máximo para que este con los niveles de ayuda que se les brinde sea capaz de adquirir un desarrollo integral.

¿Qué nos motivó a realizar este manual?

La necesidad orientar a las familias en la atención a sus hijos con disartria, para que asuman su responsabilidad con una concepción diferente en cuanto al desarrollo de estos educandos, teniendo en cuenta sus potencialidades. Se tomó en cuenta, además, las insuficiencias manifestadas por la familia, al asumir la educación de sus hijos tales como: inadecuados métodos educativos y estilos de relación, bajo nivel de expectativa con respecto a los hijos (fatalismo), insuficiente conocimiento de las particularidades logopédicas del educando, pobre estimulación de la motricidad articulatoria de sus hijos y poca comunicación intrafamiliar. Lo anterior configura las acusaciones necesarias de orientación a la familia de educandos con disartria, puestas de manifiesto en investigaciones de carácter internacional, nacional y territorial.

Contenido del Manual:

¿Qué aspectos deben de ser abordados en el manual si se pretende solucionar las necesidades anteriormente planteadas?

El manual contiene temas sugerentes y contextualizados a las realidades de las familias contribuyendo a la reflexión familiar desde el intercambio de experiencias de ejemplo

propio de acuerdo a la singularidad de cada contexto. Los temas abordados son propuestas alternativas y se pueden hacer tantas modificaciones como se consideren necesarias, siempre y cuando logren como objetivo la preparación de la familia para la atención de estos educandos

Organización y conducción de las sesiones de trabajo con los padres:

Dado el creciente interés de los padres hacia la búsqueda de mejores caminos para relacionarse con los hijos, se da la necesidad de estructurar diferentes formas de llevar a cabo la orientación familiar.

1. Es importante que la escuela esté preparada para realizar esta orientación a la familia, empleando actividades sistemáticas y prácticas que permitan la aplicación de talleres especiales favorecedores de la modificación de la conducta familiar.

2. En el primer intercambio los padres deben exponer todas las expectativas que pueden esperar al participar en el trabajo en grupo, en esta sesión se le deben de plantear los objetivos principales de trabajo y las formas en la que se presentara cada tema, deben conocer además, que cada intercambio es para discutir, reflexionar y buscar vías que conduzcan a una buena relación entre padres e hijos. Además, es importante que en el análisis que se realice con los padres se reconozca dónde están las principales debilidades en la atención a sus hijos.

Condiciones previas.

Lugar: para el estudio de las familias se debe de escoger un lugar que asegure privacidad, donde los miembros se puedan sentir libres de expresar sus ideas, puedan escuchas las reflexiones y opiniones de los participantes en el intercambio sobre las problemáticas abordadas y estas discusiones sean profundas y abiertas.

Momento adecuado: Debe ser el más conveniente para los padres, maestros y orientadores.

Duración: La escuela debe proponerles a los padres un horario que permita poder realizar la actividad, por lo que sugerimos que cada sesión tenga aproximadamente 2 horas de duración con ritmo adecuado.

Estructura del grupo: La organización de los grupos debe permitir que cada miembro pueda intercambiar, reflexionar, dar sugerencias sobre manejo de los hijos, para potenciar un desarrollo integral. Sugerimos un número de miembros que oscile entre 15 y 20.

Se debe invitar médicos, psicopedagogos, maestros, rehabilitadores y otros especialistas en determinadas materias que puedan intervenir en los talleres si es necesarios.

Preparación y características del logopeda:

El logopeda: roles y principios éticos.

La familia debe contar con un logopeda que será el encargado de dirigir las sesiones de trabajo con los padres por lo que dentro de sus funciones debe:

1. Comprender que está sucediendo con la familia: que subyace bajo la superficie; en qué etapa o fase se encuentra, como ayudarlos a liderar con los problemas que presentan tratando de buscarle la solución más razonable.

2. Hacer saber que la solución de sus problemas está definitivamente en manos de cada familia, que su función está en dotarlos de saberes y recursos que les permitan tomar la decisión más adecuada, y los miembros puedan tener una participación beneficiosa, que los haga ganar en responsabilidad y confianza en sí mismo con respecto a la educación de sus hijos.

3. Garantizar adecuada preparación de cada sesión, logrando desarrollar la adecuada habilidad para comunicarse con los participantes, saber escuchar bien y para facilitar la comunicación entre los miembros; en fin: hacer la materia de cada sesión más significativa para los miembros.

4. Ayudar a los miembros a seguir las pautas establecidas en cada sesión de trabajo. Refrenar el impulso de presentarse como una autoridad, y si demuestra una actitud asertiva hacia las familias.

5. Estar alerta con relación hacia las necesidades de cada miembro están siendo satisfechas por las familias.

6. Estimular a los miembros de las familias a funcionar a un nivel de sentimientos. Tratando de forma constructiva los sentimientos tales como el miedo, ira, dolor, culpa, depresión, auto – acusación, etc. Incluyendo sentimientos primarios muy profundos. Es un estimulador para que los miembros expresen sentimientos y actitudes y un favorecedor de una atmosfera de confianza y aceptación.

7. Mostrar aceptación de los sentimientos expresados, permitir su expresión, apoyar durante los momentos de tensión y facilitar la respuesta personalizada.

Actitudes y habilidades del logopeda.

1. Capacidad para soportar la tensión y la incomodidad personal y por parte de los miembros, así como comprensión del papel que juegan esas reacciones en los procesos de aprendizaje.

2. Disposición para ser asequible, para fomentar el interés reciproco para cada miembro.

3. Habilidad para aceptar totalmente cada uno de los diferentes puntos de vista, filosofía y actitudes, de las cuales algunas pueden ser diametralmente opuestas a las del logopeda.

4. Habilidad para concentrarse en los sentimientos y actitudes subyacentes de cada padre en particular, y del grupo en general.

5. Habilidad para promover y alimentar la interacción entre los miembros de cada familia.

6. Habilidad para ser alegre, tener sentido del humor y satisfacción en las experiencias propias y en las de los demás.

Estructura, organización y funcionamiento del Manual de orientación a la familia de educandos con disartria.

El manual para su concreción se realizará a través de talleres, ya que el autor considera que es la vía más pertinente para llegar a las familias de educandos con este tipo de discapacidad.

Se considera además que para el funcionamiento del sistema de talleres se hace necesario tener en cuenta:

- Aplicarlo manteniendo siempre un clima de confianza, interés por aprender algo nuevo en relación a las particularidades de la motricidad articulatoria del educando con disartria, que exista una concentración favorable que haga más enriquecedor el proceso.

- Escoger exhaustivamente cada uno de los ejercicios a orientar y demostrar de la forma más comprensiva posible para que no queden dudas a la hora de su aplicación.

- Tomando en consideración lo anterior los talleres se planifican en forma de sistema, de lo más simple a lo más complejo. Cuenta con ejercicios alternativos según el conocimiento y las habilidades que valle adquiriendo la familia y los niveles de asimilación.

- Cada taller está encabezado con un título para estimular y enriquecer el trabajo. Que la familia cuente con tiempo suficiente para meditar y llegar a las demostración, ejecución y control de lo orientado en el taller.

El intercambio debe ser animado, con factores sorpresa, que la palabra del familiar no fustigue sino acaricie, brinde amor y confianza para el trabajo independiente, estimule y se aplique una atmósfera creativa donde se llegue a una realidad y no un sueño inalcanzable.

Estas se aplican en el hogar preferentemente ajustado el tiempo reglamentado para el mismo. Consideramos que se tienen en cuenta elementos referentes a cómo debe ser potenciado el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Actividades que permitan al educando y a su familia determinar si logró realizar sin equivocación y con precisión, claridad y si es capaz de percatarse de algún error durante la ejecución de la misma revelando las potencialidades del desarrollo de los educandos con la patología objeto de investigación.

Actividades que permitan el uso óptimo de los programas de la Revolución, desarrollar la interdisciplinariedad, relacionadas con la Organización de Pioneros José Martí, asuman la relación con la vida como eje vertebral del trabajo correctivo – compensatorio al fortalecer el desarrollo intelectual y afectivo, mediante el enriquecimiento gradual de su sistema de conocimientos, sus experiencias y el desarrollo de habilidades, utilizando

recursos que les permitan la realización de actividades prácticas con relativa independencia para lograr la integración social.

Propuesta de talleres para la orientación a familias de educandos con disartria:

Objetivo general: Perfeccionar el proceso de orientación a familias de educandos con disartria.

Primera etapa: sensibilización y diagnóstico para la asesoría sobre la atención logopédica al educando con disartria, tiene como objetivo crear las condiciones objetivas y subjetivas para organizar el proceso de atención logopédica para el accionar conjunto del logopeda y la familia.

Acciones:

- Elaboración y aplicación de instrumentos para caracterizar las necesidades de la familia para cumplir con su función educativa.
- Desarrollo de talleres para sensibilizar a la familia sobre la necesidad de su incorporación al proceso de ayuda logopédica y de su responsabilidad con el avance o retroceso de cada uno de sus hijos.
- Determinar por consenso el contenido de orientación al trabajar para transformar la situación problemática.
- Coordinación con el maestro logopeda para el desarrollo de los talleres como parte del accionar conjunto.

Segunda etapa: de planeación de acciones transformadoras de la realidad educativa, en ella se planifican las actividades que van a hacer posible el desarrollo de los contenidos orientaciones en la asesoría.

Acciones:

- Selección del contenido orientacional:

1. Bases conceptuales de la disartria.
2. Necesidades educativas del educando con manifestaciones de disartria.
3. Cómo favorecer la comunicación del educando con disartria

4. Interacción del educando en la familia y la comunidad.

5. La organización del espacio familiar para la atención educativa al niño con disartria

6. Confección de materiales para la estimulación psicomotriz, con énfasis en la comunicación.

- Planificación de los talleres de orientación familiar
- Planeación de los momentos de asesoría a cada familia.

Tercera etapa de ejecución de los talleres de asesoría que tiene como objetivo la capacitación a la familia para que cumpla con su función educativa.

- Ejecución de talleres vivenciales. Esta forma de organización de la actividad permite trabajar los contenidos orientaciones como parte de la realidad de la práctica cotidiana, ofrecen la posibilidad de discusión de temas que apremia su solución en el contexto familiar a través de análisis reflexivos y de la polémica.
- Registro de información sobre los principales logros, dificultades, estados de opinión de las familias. Sobre la información recogida se perfeccionan los próximos talleres.

Cuarta etapa de evaluación y retroalimentación del proceso de asesoría a la familia tiene como objetivo constatar las principales transformaciones ocurridas en la familia.

Acciones:

- Recogida de la información de los estados de opinión, las principales barreras, el modo en que se produce la interacción del orientador y los orientados y cómo ocurre el proceso de interacción de la familia y los educandos.
- Procesar la información y reajustar las acciones de asesoría.

Momentos en los que se realizarán los talleres:

1. Preparación previa del tema: en el momento de preparación del tema seleccionado, se comienza con una rueda breve de comentarios sobre la importancia del tema, sobre el conocimiento que poseen los participantes acerca del mismo. Se presenta tema y objetivo.

2. Momento intermedio: se retoman los objetivos, es el momento en que la familia participa activamente expresando lo que conoce sobre el tema, como actúan, sus inquietudes, se harán comentarios, reflexiones e intercambios provocados por interrogantes planteadas. El orientador que es el logopeda expone una breve explicación integrando las inquietudes planteadas y ofrecerles aclaraciones que sirven de elemento de análisis y obtención de conocimientos válidos para enfrentar el trabajo con los educandos. Este momento debe ser breve, preciso, hay que evitar el sermón, es decir, una larga explicación.

3. Cierre del tema: es el momento de reflexión final, de arribar a conclusiones, de evaluar la participación. Se determina lo positivo, lo negativo y lo interesante de cada taller (ver anexo 1)

Talleres de Orientación familiar para el desarrollo de la motricidad articulatoria a educandos con disartria:

Taller 1

Tema: Conociendo a mi hijo con disartria.

Contenido: El educando disártrico. Sus principales manifestaciones clínicas.

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Objetivo: Analizar las principales manifestaciones sintomatológica del educando con disartria.

Método: Debate

Metodología Momento inicial: Se comenzará con un debate donde se expresan las ideas sobre el tema. Se presenta el objetivo de la actividad y la familia expone brevemente los conocimientos que posee sobre el tema a debatir.

Momento intermedio: Se realizará mediante una técnica participativa en la que se harán preguntas relacionadas con las formas que se manifiesta el cuadro sintomatológico de la disartria, enfatizando en la motricidad general y articulatoria.

Otras preguntas a realizar a los padres están relacionadas con el lenguaje y las principales dificultades que tienen al expresarse. Una vez que los padre hayan referido

las principales manifestaciones sintomatológica de sus hijos y han descripto las particularidades del habla, así como lo que más les preocupa sobre esta logopatìa verbal, el logopeda realizará una explicación del cuadro sintomatológico de la disartria, enfatizando en su repercusión en la personalidad de sus portadores.

Posteriormente se les da la palabra a los padres los cuales expondrán sus dudas, puntos de vista. El logopeda realizará las aclaraciones pertinentes de las inquietudes que surjan de los padres u otros familiares.

Seguido de esto se les explica un ejercicio que pueden realizar en cualquier momento del día, que es un ejercicio de relajación y respiración (Inspiración nasal y espiración bucal)

El ejercicio comienza inclinando la cabeza hacia adelante, mientras realizas una inspiración profunda, llenando la parte inferior de los pulmones, como sube el abdomen. A continuación realiza la espiración llevando la cabeza a su posición normal. Ahora pueden realizar la siguiente inspiración subiendo la cabeza hacia arriba y tras ello espíralo bajando de nuevo la cabeza a su posición inicial.

Tras ello realiza la siguiente inspiración girando la cabeza al lado derecho y después vuelve a llevar la cabeza a su posición inicial soltando el aire. Ahora de nuevo, realiza una inspiración girando la cabeza hacia el lado izquierdo y volviendo la misma posición del medio una vez valla espirando el aire.

El siguiente ejercicio se realiza cogiendo aire mientras flexionas lateralmente el cuello, como si pretendieras tocarte el hombro con la oreja derecha, y una vez conseguido expulsa el aire por la boca volviendo la cabeza a su posición inicial. Luego repite el ejercicio hacia el lado izquierdo.

En este momento, inicia un movimiento circular hacia el lado derecho con el cuello, como si quisieran dibujar un círculo grande con la nariz, y realiza una inspiración profunda, una vez que hayas terminado de coger aire, empieza a soltarlo por la boca mientras continua con el movimiento circular. Realiza del mismo modo el ejercicio pero realizando el movimiento al lado contrario (realiza toda la serie anterior tantas veces como te resulte cómodo).

Ahora pasamos a realizar la respiración moviendo los hombros y los brazos, de modo que puedes comenzar elevando los hombros mientras realizas una inspiración profunda, tras la cual podrás bajarlos, relajados, mientras exhalas el aire por la boca.

La siguiente modalidad consiste en inspirar mientras haces girar los hombros hacia delante, imaginando que hacer círculos con los mismos, mientras que después en la espiración puedes cambiar la dirección y realizar los círculos hacia atrás. Una variante de este ejercicio es realizar primero movimientos hacia delante, incluyendo inspiración y espiración y en segundo lugar, hacia atrás.

Es momento ahora de subir de frente y hacia arriba el brazo derecho mientras realizas una inspiración profunda y después bajarlo realizando la espiración bucal. A continuación realiza el mismo movimiento con el brazo izquierdo. Puedes hacer este ejercicio o bien subiendo las manos de una en una o bien las dos a la vez.

Ahora sube ambos brazos hacia arriba de manera lateral mientras realizas la inspiración, para una vez llevado a cabo, soltar el aire por la boca bajando los brazos.

Colócate este momento tumbado boca arriba, pueden colocar encima de su abdomen algún peso, como por ejemplo un libro, y comienza a realizar la inspiración notando que sube su abdomen al hacerlo, luego comienza a botar el aire por la boca notando como el libro desciende.

Momento final: Se realizan las conclusiones del tema abordado, enfatizando en las principales manifestaciones clínicas de la disartria, las afectaciones que se producen tanto en la motricidad general y articulatoria y como ellos deben contribuir desde el hogar a la corrección y/o compensación del trastorno.

Se enfatiza en que la finalidad de estos ejercicios está dirigido a ajustar la velocidad del habla, mejorar el uso de la respiración, mejorar la articulación de los sonidos afectados y de palabras, fortalecer la musculatura facial, aumentando el movimiento de la boca, la lengua, los labios y la mandíbula.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada, teniendo en cuenta los criterios de los padres

Taller 2

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: La relajación corporal en el educando disártrico

Contenido: Las técnicas de relajación y su espacio en el hogar para propiciar una mejor movilidad y equilibrio del escolar con disartria.

Objetivo: Identificar diferentes técnicas de relajación, para propiciar una mejor movilidad y equilibrio a emplear en el espacio familiar que propicie una mejor movilidad y equilibrio en el educando disártrico.

Método: Demostración ejecución

Metodología

Momento inicial: Se comenzará con una rueda de comentarios acerca de qué entiende la familia por relajación, movilidad, equilibrio; en qué momento del día es más propicio realizar estos ejercicios con sus hijos y cómo lo realizan. Se invitará a un fisioterapeuta que apoyará con la demostración de los ejercicios.

Se presenta el tema y el objetivo propuestos para la actividad.

Momento intermedio: Este momento es muy importante, se retoma el objetivo y como primer momento de la actividad se le pide a los padres que formen dúos afines para practicar los ejercicios. El logopeda y el fisioterapeuta tomarán a uno de los padres para realizarle el ejercicio o masaje y los demás imitarán los movimientos mientras los especialistas irán explicando en qué consiste y por qué se realiza de esa forma, sus ventajas e importancia. En un segundo momento de la actividad los dúos formados intercambiaran de roles para que el padre que estaba recibiendo el ejercicio pueda practicarlo también.

Se enfatizará que en el tratamiento corporal se interviene en el control postural, siendo este uno de los primeros objetivos de intervención por su incidencia en la ejecución de las funciones relacionadas con el sistema orofacial, el cual interviene la respiración, succión, masticación, deglución, articulación y fonación.

Momento final: Se harán las conclusiones a través de preguntas: ¿Crees que es importante la relajación corporal para ayudar a tu hijo en su desarrollo psicomotor?

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 3

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Cómo desarrollar la motricidad y el equilibrio a través del baile

Contenido: Desplazarse manteniendo el equilibrio a través del baile de la canción pie, pie, pie.

Objetivo: Explicar las formas de desarrollar la motricidad y el equilibrio.

Método: Demostración

Metodología

Momento inicial: Se hará a través de la presentación de una situación problemática donde los participantes evaluarán el caso a sus criterios basándose en sus experiencias. Se presenta el tema y el objetivo.

Momento intermedio: El padre invita a tu hijo a participar junto a él, utiliza frases como: “Hoy tenemos una nueva actividad para el descubrir el movimiento, ¿quieres descubrirla conmigo?” “¿De qué crees que tratará?”. Explícale a tu hijo el objetivo: “Hoy mantendremos el equilibrio a través de movimientos corporales con la canción pie, pie, pie”.

Por un momento el niño escuchará la canción con atención y se mueve libremente al ritmo de ella, haciendo énfasis en su contenido: “Antes de comenzar, escucharemos con atención la canción que se llama pie, pie, pie” “Veo que ya quieres comenzar a bailar por cómo mueves tu cuerpo”.

Luego, vuelvan a escuchar la canción e invita a tu hijo a bailar: “Ahora nos pondremos de pie y pondré nuevamente la canción”. “Podemos seguir los pasos de la canción, pero sin perder el equilibrio, para eso haremos una ronda juntos y bailaremos la canción”. “¿Qué estamos haciendo?” “¿Qué parte de nuestro cuerpo movemos?” “¿Qué te parece tener que combinar movimientos?” “¿Qué es lo que te gusta de la canción?”

Para finalizar la actividad usa las siguientes frases: “Ya terminó el descubrir el movimiento, vamos a recordar lo que hicimos”. “¿Cómo se llama la canción?” “Hoy bailamos la canción pie, pie, pie. Podíamos mover nuestro cuerpo, pero sin perder el equilibrio, hubo momentos que casi caí, mientras que mantuviste el equilibrio durante toda la actividad”.

Los niños aprenden a favorecer el equilibrio y motricidad y reconocer partes del cuerpo.

Momento final: Se harán las conclusiones con el análisis de la situación problemática presentada al inicio, las respuestas que fueron correctas y las incorrectas, fundamentando la problemática planteada, aclarando dudas y preocupaciones de cada participante.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 4

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: El desarrollo de la motricidad articulatoria en los niños disartricos

Contenido. Cómo lograr el control bucal y postural en el niño disartrico.

Objetivo: Demostrar cómo hacer uso de la respiración, mejorar la articulación de los sonidos afectados y de palabras, además de fortalecer la musculatura facial, aumentando el movimiento de la boca, la lengua, los labios y la mandíbula.

Método: Observación

Metodología

Momento inicial: Se motivará la actividad mostrando a la familia varios ejercicios a realizar en el hogar para el desarrollo de la motricidad articulatoria, además de fortalecer la musculatura facial y de ésta forma favorecer el movimiento de la boca, la lengua, los labios y la mandíbula.

Momento intermedio: En este momento los participantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con los ejercicios donde se le realizará por parte del logopeda uno de ellos

Propuesta de actividades:

Actividad 1. Cerrado forzoso labial, 5 veces durante 5 segundos cada uno y relajar los labios entre una y otra un par de segundos.

Actividad 2. Gesticular un beso (con sonido) 5 veces.

Actividad 3. Sonreír sin abrir los labios 5 veces y después de cada vez, relajar la musculatura labial.

Actividad 4. Morderse el labio superior 5 veces y luego el inferior otras 5. A continuación lo vamos alternando (1 vez el superior, 1 vez en inferior) 10 veces.

Actividad 5. Hacer vibrar los labios durante 10 segundos, 5 veces.

Actividad 6. Con 2 botones de diferente tamaño, atados con hilo dental.

En cada actividad se les solicita a los padres demostrar las actividades para valorar su nivel de comprensión para la realización con sus hijos cuando estén solos en casa.

Momento final: Se concluye la actividad con dos preguntas: ¿Cuál de estas actividades considera que mejor pudieran utilizar con sus hijos para cubrir las necesidades de tu hijo?

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 5

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: ¡Vamos a jugar!

Contenido: Adaptaciones de los juegos para lograr una infancia plena.

Objetivo: Identificar vías para adaptar algunos juegos infantiles que permitan la interacción de la familia con el educando con disartria, contrarrestando la sobreprotección de los padres hacia sus hijos y estimulando su desarrollo motor.

Método: Preguntas y respuestas

Metodología

Momento inicial: Se abre este momento con una pregunta para reflexionar: ¿Puede mi hijo realizar algún juego donde no se lastime o frustre por su condición física?, ¿Estos juegos pueden contribuir a desarrollar su motricidad gruesa y fina?

Se presenta el tema y el objetivo.

Momento intermedio: En este momento se pasará a realizar las preguntas previstas para la sesión, al final de cada una la familia tendrá un momento para reflexionar e intercambiar opiniones, ideas y puntos de vista, luego se procede al intercambio general donde cada uno expresará lo que piensa con respecto al tema o interrogante planteada. Algunas de las interrogantes están precedidas de una pequeña situación cotidiana que puede presentarse en el momento de juego, por lo que la familia deberá opinar acerca de qué solución le darían en caso de que les ocurriese, o que posición tomarían en un momento determinado.

Momento final: Se realizan las conclusiones precisando que a veces los juegos que creemos más seguros no son aquellos que le ofrecen seguridad a nuestros hijos, sino los que con un poco de riesgo o emoción para ellos les despierta la curiosidad y el deseo de vivir una infancia plena, provechosa y sin barreras a pesar de sus condición.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 6

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Cómo fortalecer el equilibrio y la fuerza**.**

Contenido: “El globo que vuela”

Objetivo: Desarrollar el aparato locomotor y fortalecer las habilidades motrices

Método: Conversación y demostración

Metodología

Momento inicial: en este momento se procede a informar a la familia que la actividad se realizará en trabajo conjunto con los padres y el profesional para poder estimular desde

muy pequeños los movimientos de los niños, siguiendo las recomendaciones del especialista.

Se pueden adaptar las actividades a distintas edades e ir aumentando poco a poco el grado de complejidad en correspondencia con las particularidades de cada niño. Lo más importante es llenar de afecto y optimismo al menor para que se sienta motivado y apoyado para lograr sus objetivos.

Momento intermedio: En este momento se procede a presentar el juego “El globo que vuela”

Este es un entretenido juego para niños limitaciones motora. Además, es muy fácil de ejecutarlo y solo necesitarás varios globos. Si el niño presenta inamovilidad en los extremos superiores, puede jugarlo con las extremidades inferiores o viceversa. Se puede jugar de la siguiente manera:

1. Ordena a los participantes que formen un círculo.
2. Pueden estar de pie, sentados o en su silla de ruedas.
3. Lanza varios globos al aire, pero tratando de que caigan dentro del centro del círculo donde están los participantes.
4. El objetivo es que agarren la mayor cantidad de globos posibles y que la pasen en grande.

   Se puede aprovechas la interacción con los globos e invitar al niño a soplar, de esta forma ejercitamos la respiración como elemento fundamental para el acto del habla.

Momento final: Se concluye la actividad con una pregunta: ¿Crees ahora que tu hijo puede compartir el juego con otros educandos con o sin NEE?

Se les enfatiza a los padres en la necesidad de crear juegos que propicien la interacción con otros niños y que contribuyan a una mejor interacción social.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 7

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Diferentes vías de comunicación (SAAC)

Contenido: Los instrumentos y medios que pueden constituir a los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación (SAAC)

Objetivo: Valorar los instrumentos y medios necesarios para lograr una comunicación efectiva ya sea con la utilización de sistemas o no.

Método: Observación y explicación

Metodología

Momento inicial: Este momento parte de una interrogante: ¿Cuáles son las necesidades comunicativas que tiene mi hijo? Se presenta el tema y el objetivo.

Momento intermedio: En este momento se le reparte a la familia hoja y lápiz y se le indica hacer una lista de aquellas cosas que en la vida cotidiana se le dificulta comunicar con más frecuencia a sus hijos por sus características o condiciones derivadas de la disartria, como las necesidades básicas de alimentación, necesidades fisiológicas, alcanzar objetos, escoger la ropa, trasladarse a otra habitación, etc. Luego se procede a un intercambio donde cada familiar leerá o explicará lo que escribió en su lista y que a su hijo se le dificulta comunicar con más frecuencia en el día a día.

A continuación se le muestra a la familia un ejemplo de tablero donde se pueden pegar láminas o dibujos, recortes de un libro, zunzún o revista donde aparezcan estas necesidades o acciones que el educando desea realizar más a menudo y que se le dificultan a la hora de comunicarlas por el estado del aparato articulatorio, la poca movilidad o rigidez de los órganos que intervienen en el habla o la espasticidad de algunas zonas como la musculatura de la cara o el cuello. Seguidamente el logopeda explicará los materiales necesarios para hacer el tablero y los pasos a seguir para realizarlo según las necesidades individuales.

Momento final: Se aclaran las dudas e inquietudes de los familiares y se concluye la actividad dejándole a cada padre la tarea de buscar los recortes para el tablero según sus necesidades individuales.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada y en las visitas al hogar posteriores a la aplicación del taller donde se corrobora el cumplimiento de la tarea.

Taller 8

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Estimulación de los órganos articulatorios del niño con disartria

Contenido: Ejercicios para entrenar los órganos articulatorios del lenguaje

Objetivo: Desarrollar los órganos articulatorios en función de una correcta articulación y pronunciación

Método: Demostración

Metodología

Momento inicial: El logopeda iniciará presentando la actividad, enfatizando en la importancia de estos ejercicios para el desarrollo de la correcta articulación y el lenguaje de los niños con disartria. Se puede invitar a un fisiatra, como forma de enriquecer el debate e intercambio con los padres, este iniciará con una rueda de intercambios a partir de las preguntas: ¿Qué actividades o ejercicios realizan en casa que contribuya a estimular los órganos articulatorios? ¿Qué otras actividades realzan en casa con sus hijos que favorezca el desarrollo de los órganos articulatorios? Se presenta el tema y el objetivo

Momento intermedio: Se procede a presentar los ejercicios y su demostración del logopeda conjuntamente con el fisiatra.

Ejemplos de ejercicios:

- Estiramientos de los labios A la mayoría de los niños les encanta hacer muecas,
- Flexibilidad de los labios
- Fortalecimiento de las mejillas
- Movilización de la lengua
- Reforzamiento de la lengua

Cada padre tendrá la posibilidad y deberá demostrar ante un grupo de padres los ejercicios para que luego los puedan realzar de forma correcta cuando estén a solas con sus hijos.

Momento final: Se realizan las conclusiones precisando la necesidad de la sistematización de estos ejercicios.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 9

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Cómo involucro a mi hijo en las actividades cotidiana en el hogar

Contenido: El rol del educando disártrico en el hogar.

Objetivo: Identificar roles que el educando puede asumir como un miembro de la familia y que le permitirán desarrollar su motricidad articulatoria.

Método: Debate

Metodología

Momento inicial: Se debatirán las experiencias de los participantes acerca del rol que juegan sus hijos dentro de la familia. Se presenta el tema y el objetivo.

Momento intermedio: Se hará un análisis de cuáles son aquellas actividades, tareas o situaciones en el hogar que determinan el rol que juega el educando en la familia y de forma se puede enriquecer su motricidad articulatoria dichas actividades, es importante que la opinión de éste sea tomada en cuenta para determinar las decisiones del hogar. El educando no debe sentirse excluido, apartado por su condición, forma de articular o caminar, y hasta marginado porque no pueda expresar lo que piensa o siente como el resto de la familia, debe tener una vía para comunicar lo que es de su agrado o no.

Momento final: Se concluye la actividad con la pregunta: ¿Cumple mi hijo con su rol dentro de mi familia?

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

Taller 10

Tipología o vía metodológica: Taller vivencial

Tema: Mis derecho y deberes en el contexto social

Contenido: Los derechos y deberes del educando disártrico en los diferentes contextos.

Objetivo: Identificar los derechos y deberes del educando como miembro de la familia, la escuela y la sociedad.

Método: Preguntas y respuestas

Metodología

Momento inicial: Se comienza la actividad con el planteamiento de una pregunta: ¿Cuáles son los deberes y derechos de mi hijo? Se presenta el tema y el objetivo.

Momento intermedio: En este momento se le indica a la familia realizar una lista de aquellas cosas que consideran importantes y que constituyen derechos y deberes de los educandos sin importar su condición:

Deberes	Derechos
Cumplir con las tareas que se le pongan	A ser tomados en cuenta, ser respetados
Cumplir con las normas y reglas del hogar	A la educación y cuidados especiales
Tienen el deber de estudiar	A ser amados sin importar su condición, raza o sexo
Cumplir con la organización y los horarios de sus actividades	A disfrutar de alimentación, vivienda y servicios médicos adecuados

Respetar a los adultos	Ser comprendidos y cuidados sin importar su condición física o mental
Tienen el deber de ser educados y corteses con quienes los rodean	Tener un hogar, familia, amigos sin ser discriminados ni apartados por su condición

Momento final: Se hacen las conclusiones precisando que el hecho de que estos educandos presenten ciertas dificultades por su condición no los exonera de cumplir con algunos deberes indispensables para su educación y realzando la importancia del cumplimiento de sus derechos con toda cabalidad.

Evaluación: Se realizará en la apreciación sistemática de los resultados obtenidos en la actividad ejecutada.

2.3. Validación de la pertinencia y factibilidad del manual de Orientación familiar para educandos con disartria.

Con vista a corroborar la utilidad, pertinencia y factibilidad de la propuesta se somete a valoración utilizando diferentes métodos y técnicas, tales como:

Resultados de la aplicación del método de resolución de problemas con experimentación sobre el terreno.

Para la valoración de los resultados de los talleres de orientación a familias de educandos con disartria se emplea el método de resolución de problemas con experimentación sobre el terreno, pues propició la descripción de los diferentes momentos por los que atraviesa el estudio y retroalimentación del proceso. Para ello se consulta la propuesta de Colas y Buendía donde se exponen los momentos siguientes:

1. Exploración y análisis de la experiencia en torno a la orientación familiar de educandos con disartria.

2. Enunciado del problema de investigación que se identifica en torno al objeto de estudio.

3. Planificación del proyecto de solución del problema.

4. Realización del proyecto.

5. Presentación y análisis de los resultados.

6. Interpretaciones, conclusiones y toma de decisiones.

Para el análisis y puesta en práctica del método se procedió a la operacionalización de la **Variable dependiente**. El proceso de orientación a la familia para la estimulación del desarrollo de la psicomotricidad del educando con disartria. Definición de la variable: dotar a los padres del saber, el saber hacer y el saber ser para estimular el desarrollo físico, intelectual y social de educandos con disartria, para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiere sido sin este entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad.

Variable independiente: Manual de orientación a la familia para la estimulación de la psicomotricidad de los educandos con disartria.

A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del método.

Exploración y análisis de la experiencia en torno a la orientación familiar a educandos con disartria:

A partir de la triangulación de la información obtenida de las visitas al hogar, y las entrevistas se pudo obtener como resultado que de 10 familias de educandos con disartria siete de ellas, que representan el 70%, no estimulaban al educando para favorecer posturas al sentarse, caminar, articular los sonidos, tragar, correr o jugar; tres de ellas, que representa un 30 % no propiciaban un espacio de relajación, así como el uso de las técnicas adecuadas; 1 que representa el 10% de las familias poseía información y utilizaba las técnicas adecuadas para preparar los alimentos y su forma de administración; solo 2 familias correspondientes a un 20% estimulan en sus hijos la importancia de lograr independencia al realizar actividades como vestirse, peinarse, cepillarse según sus posibilidades.

El 10% de las familias no conocen cuales son los juegos adecuados según las características de sus hijos para estimular el desarrollo de la motricidad articulatoria 3 para un 30% no tenían conocimiento de la existencia de algunos deportes que sus hijos pueden practicar a pesar de sus particularidades; 4 familias que representan un 40% no conocían otras técnicas o vías como los Sistemas Alternativos y Aumentativos para facilitar la comunicación de sus hijos que no fuera por mímicas o gestos en los casos que

se encuentra afectada la comunicación en su forma más severa; 5 para un 50% se avergonzaba de las características físicas y psicológicas de sus hijos; 7 que representa el 70% sobreprotegían a sus hijos y no les brindaban la posibilidad de ocupar su verdadero rol dentro de la familia; solo 1 que corresponde a un 10% conocían los derechos de sus hijos y les hacían saber sus deberes ante la familia, la escuela y la sociedad.

Este resultado permite constatar que es insuficiente la preparación de la familia en la realización de actividades psicomotrices que le permiten un desarrollo pleno, y como principal carencia se demostró la falta de puesta en práctica por parte de la familia de los recursos, habilidades, orientaciones y tareas para mejorar la psicomotricidad articulatoria del educando con disartria. Para un mejor estudio de estas familias se tuvo en cuenta una guía de aspectos generales que dotó al autor de información relevante para dirigirse a este grupo específico. (ver anexo 3)

A través del desarrollo de los talleres el autor fue recogiendo los datos de mayor importancia e impacto que se fueron obteniendo durante la aplicación de los mismos tanto en las familias como en el educando y su entorno. Luego de haber desarrollado todos los talleres se obtuvieron resultados positivos y superiores en comparación con los resultados de la constatación inicial que demuestran las posibilidades que tiene la familia como protagonistas en el proceso educativo para potenciar el desarrollo psicomotriz de sus hijos, además de la importancia de la relación entre el logopeda y la familia en este proceso. Estos resultados se evidencian en los elevados por cientos (%) obtenidos en la constatación final que se muestra más adelante, y dan muestra de la necesidad de proponer acciones que posibiliten la acción orientadora del maestro logopeda con ellas. A partir de estos resultados se procede a cumplimentar la segunda acción del método consistente en ***Enunciar el problema de investigación*** que se identifica en torno al objeto de estudio. Queda formulado el problema del siguiente modo ¿Cómo organizar el proceso de orientación familiar para la estimulación del desarrollo de la motricidad articulatoria en educandos con disartria?

En la acción número tres del método de ***Planificación del proyecto de solución del problema*** se toma la decisión de incluir dentro de las acciones el taller como una de las

vías a emplear en la asesoría, así como, las asesorías individuales para trabajar necesidades colectivas e individuales. Se decide el taller vivencial porque favorece el aprendizaje de los participantes a partir de la experiencia de los otros y permite modificar los mitos, las formas de hacer y de pensar que son barreras para la relación de la familia con el educando.

En la **Realización del proyecto** como cuarta acción del método se ejecutan las acciones planeadas para cada etapa. Para cumplir con el objetivo de dicha etapa se emplea como recurso el diario de campo donde el investigador anota los hechos más significativos de las sesiones de trabajo donde se precisa la evolución de la familia a lo largo de la implementación de la propuesta: cuatro de las diez familias, al iniciar la propuesta, se mostraron en desacuerdo con la ayuda que se le brindaba al alegar que era innecesario y una pérdida de tiempo porque sus hijos no cambiarían, con la ayuda de los demás padres y otros agentes educativos se logró que a partir de la tercera y cuarta sesión se incorporara la totalidad de las familias lo que propició posteriormente su oportuna e imprescindible cooperación en este proceso, que de evidencia en la adquisición del conocimiento y puesta en práctica de la propuesta por parte de la familia, además se logró que la familia comprendiera que la intención no es hacer cambiar a sus hijos, sino dotarlos del conocimiento para modificar su accionar ante ellos y modificar las condiciones del entorno para su beneficio, somos nosotros los que debemos cambiar.

Se recomienda profundizar en el estudio de la formas de alimentación de los educandos con disartria que requieren ayudas técnicas u otros métodos para la preparación de sus alimentos. El autor concibió cada taller con la misma cantidad de horas, lo que no significa que a cada tema se le dedicara el mismo tiempo porque para dar seguimiento a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por la familia se realizaron visitas individuales, las que se aprovecharon además para darle salida a dudas u otros temas que algunos padres no querían tratar en el grupo, pero se declara que los temas de más polémica y en los que hubo que utilizar mayor tiempo fueron en la utilización de los SAAC, el rol del educando dentro de la familia y la aceptación en la familia de un educando con disartria.

CONCLUSIONES:

El estudio bibliográfico y la aplicación de métodos de investigación permiten arribar a las consideraciones siguientes:

1. Los principales fundamentos teóricos y metodológicos existentes sobre la labor del maestro logopeda en la orientación a la familia del educando con disartria para la estimulación del desarrollo psicomotriz se establecen desde las normativas del trabajo logopédico donde se precisa la función orientadora de este profesional, desde los fundamentos de la corriente integrativa de la orientación y del enfoque comunicativo que presupone el empleo de todas las vías posibles para lograr la comunicación ya sea por elementos verbales y no verbales.

2. Se constata que dentro de las particularidades del desarrollo del educando con disartria que condicionan el proceso de orientación familiar se encuentran la presencia de desórdenes psicomotrices que pueden estar acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento. Estas particularidades pueden exacerbarse en dependencia de la relación del educando con su medio.

3. La caracterización del estado actual del proceso de orientación a familias de los educandos con disartria arrojó que el grupo de familia con el que se trabajó no posee un nivel amplio de preparación que se corresponda con las necesidades que devienen de la interacción de sus hijos con el medio dentro de ellas las de naturaleza psicomotriz, cognitivas, sensoriales, comunicativas y sociales.

4. La propuesta de talleres de orientación familiar para la estimulación de la psicomotricidad en el educando con disartria se estructura a partir del contenido orientacional que se revela de la caracterización de estos educandos y de su familia.

5. La aplicación en la práctica de los talleres de orientación familiar del educando con disartria ofrece criterios de pertinencia pues el personal que se escogió para esta investigación quedó dotado de conocimientos precisos sobre las condiciones de desarrollo de los educandos con esta patología verbal, sus dificultades y cómo manejarlas, logrando así un desarrollo pleno y una mejor calidad de vida en sus hijos.

RECOMENDACIONES:

- Profundizar en el accionar del logopeda con los educandos que reciben atención educativa ambulante.
- Continuar indagando en el tema abordado e incluir para talleres futuros otras aristas no trabajadas como la sexualidad de los educandos con disartria y cómo manejar este tema en el hogar y en la escuela, cuáles son las oportunidades de formación laboral y trabajo de estos educandos teniendo en cuentas sus característica personológicas.

Bibliografía:

Acosta, V. (2014). Efectos de un programa de intervención en el lenguaje en alumnado con trastornos específicos del lenguaje. Revista de Investigación en Educación, 12(1), 92-103. Recuperado el 20-9-2018 de http://webs.uvigo.es/reined/

Acosta, V., Moreno, A. y Axpe, A. (2012). Efectos de un programa de intervención en el lenguaje sobre el desarrollo del léxico y del procesamiento fonológico en escolares de educación infantil con trastorno específico del lenguaje. *Revista de Investigación Educativa*, 30(1), 7186. Recuperado de: http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/113861/140091

Águeda Soria, O. R. (2015) *Propuesta de intervención con alumnos con Parálisis Cerebral. Una mirada inclusiva.* Universidad de Valladolid. Valladolid.

Álvarez Lami, L., Fernández Collazo, L., Ferrer Sarmiento, A., López Betancourt, M., Capó Alonso, M. T., Regal Cabrera, N., Castellano Toro, G., Sardiñas Peña, Á., Pazo Quintana, T., Cabrera Díaz de Arce, I., Montesino Bejerano, E., Ochoa Barrientos, N., & Rodríguez Gómez, A. M. (2008). *Logopedia y foniatría*. Ciencias Médicas.

Antolín M. (2006) *Cómo estimular el desarrollo del niño y despertar sus capacidades.* Argentina

APA. (2013). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5*. Asociación Americana de Psiquiatría. www.psych.org

Badia Corbella, M. (2006) *Hacia una educación inclusiva: el caso de los alumnos con parálisis cerebral.* Universidad de Salamanca. Salamanca.

Buendía Eisman, L., Colás Bravo, M. P., & Hernández Pina, F. (1998). *Métodos de investigación en psicopedagogía*. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Busto Barcos, M. del C. (1993*) Reeducación del habla y el lenguaje en el paralítico cerebra*l. Editorial CEPE. Madrid.

Calzada Vázquez, C, Vidal Ruiz, C. A. (2014) Parálisis cerebral infantil: definición y clasificación a través de la historia. *Revista Mexicana de Ortopedia Pediátrica* Vol. 16, Núm. 1.

Camejo, Lluch, R, (2015) *La familia y su estructura*. Recuperado de: https://ebookcentral.proguest.com//ib//utasp/reader.action?doc.ID: 4310152

Casas, G. (1994) Antología de familia y terapia familiar sistémica. Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social.

Chernousova L. (2008) *La estimulación de la comunicación verbal de los niños con Necesidades Educativas Especiales en el desarrollo general del lenguaje*. Tesis de doctorado. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero". Holguín.

Cobas Ochoa, C. L. (2010). *Temas logopédicos para los docentes*. Editorial Pueblo y Educación.

Colás Bravo, M. P., & Buendía Eisman, L. (1992). *Investigación Educativa*. Ediciones Alfar S.A.

Collazo Delgado, B. Puentes Alba, M. (1992) *La orientación en la actividad pedagógica: ¿El maestro, un orientador?* Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

Cruz Zurita, C. (2009) *La atención educativa en la primera infancia de los niños con limitaciones físico –motora*s. Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas Ciudad de La Habana.

Cruz Zurita, C. (2010) *Manual de orientación a los agentes educativos comunitarios*. La Habana. Cuba.

de Armas Ramírez, N., & Valle Lima, A. (2011). Resultados científicos en la investigación educativa. Editorial Pueblo y Educación.

Engels, F. (1963). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La Habana: Ciencias Sociales.

Espinal, I, Gimeno, A, González, F, (ND) *El enfoque sistémico en el estudio sobre la familia.* Recuperado de: https://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20sistemico. Pdf

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008a). *Atención a los niños con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje en Cuba.* Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008b). *La Atención Logopédica en la Edad Infantil.* Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G., & Huepp Ramos, F. (2014). *Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G., & Rodríguez Fleitas, X. (2012). Logopedia Primera Parte. Pueblo y Educaciòn.

Figueredo Escobar, E., Nieves Rivero, M. L., Pérez González, S., & Borges Rodríguez, S. (1984). Logopedia. Tomo I. Editorial Pueblo y Educación.

Funnie, N.R, (1976) *Atención en el hogar del niño con parálisis cerebral* Editorial Fournier, S.A., México

García de la Figal Costales, A. E. (2016). Teoría y metodología de la investigación científica. Editorial Universitaria Félix Varela.

García Prieto, A. (1999) *Niños y niñas con parálisis cerebral: Descripción, acción educativa e inserción social*. Ediciones Narcea.

González Picarín A. (2014) *La atención logopédica en el nivel primario de educación*. Tesis de doctorado Universidad de Ciencias pedagógicas. Holguín

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación.* McGRAW-HILL

Iliasov, I. I., & Liaudis, V. Y. (1986). *Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades*. Editorial Pueblo y Educación.

Jeannette, C, (2018) *Algunas reflexiones sobre la familia actual*. Recuperado de : https://www.psicologia-online.com/algunas-reflexiones-sobre-la-familia-actual-2636.html

Levitt, S. (1994) *Tratamiento de la parálisis cerebral y retraso motor*. Editorial Médica Panamericana.

López dos Santos, A. B. (2016) *Lenguaje y comunicación en Parálisis Cerebral. Respuesta educativa. Intervención logopédica*. Universidad Pontifica de Salamanca. Salamanca.

López Pérez, Y. (2000) *Evaluación de la Función Motora Gruesa en niños con Parálisis Cerebral en Laboratorio de Evaluación Psicomotriz del CIREN*. Reporte Preliminar. Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN). Ciudad de La Habana. Cuba.

Lorene, H. (2000) *La parálisis cerebral. Actualización del concepto, diagnóstico y tratamient*o. Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Sabadell. Barcelona.

Madrigal Muñoz, A. (2007) Familias ante la parálisis cerebral. *Psychosocial Intervention* vol. 16 no.1 Madrid.

Martín Pérez, M., Prado Alfonso, R., & Méndez Montí, I. (1980). *Los métodos para el tratamiento logopédico*. Editorial Pueblo y Educación.

Martínez, S. A. (2017) *La formación permanente del maestro de educación especial para la atención a la niña y el niño de cero a tres años de edad con parálisis cerebral*

Monfort, I., Monfort, M., & Juárez Sánchez, A. (2014). Investigación y práctica profesional en logopedia. *Revista de Neurología Española,*, *58*(S1), 111-115.

Moreno Manso, J.M. y Montero González, P.J. (2004) *Evaluación psicoeducativa de la parálisis cerebral*. Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Mérida.

Moreno Manso, J.M.; Montero González, P.J. y García-Baamonde Sánchez, M.E. (2004) *Intervención educativa de la parálisis cerebral. Actividades para la mejora de la expresión oral.* Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Mérida.

Nocedo de León, I., Catellanos Simons, B., García Batista, G., Addine Fernández, F., González Dosil, C., Gort Sánchez, M., Ruiz Aguilera, A., Minujín Zmud, A. F., & Valera Alfonso, O. (2001). Metodología de la investigación educacional. Segunda Parte. Pueblo y Educación.

Organización Mundial de la Salud, (2000) *Fomento del Desarrollo del Niño con Parálisis Cerebral*.

Pérez Rodríguez, G., García Batista, G., Nocedo de León, I., & García Inza, M. L. (2009). *Metodología de la investigación educacional. Primera parte*. Editorial Pueblo y Educación.

Pérez, D.F,(2017) *Funcionamiento familiar saludable*. Recuperado de: https://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciontemprana/funcionamiento-familia.pdf

Pestalozzi J. E (1746). Como Gertrudis ensena a sus hijos. Editorial Madrid.

Quíntela Cabrera, L. (2001) *Alternativas para el trabajo con la familia del niño con necesidades educativas especiales*.

Rodríguez Arbelo, C. Rodríguez Hernández, S (2016) *Atención Temprana en Parálisis Cerebral Infantil.*

Rodríguez, J. y otros. (1990). *La educación familiar en Cuba. Experiencias y posibilidades.* Pedagogía 90. Impresión ligera. ISP: “Enrique José Varona”.

Romero, F. (1998). Justificación de la existencia de los Centros de Orientación Familiar. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Ríos, J. A. (1994). Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid: Instituto de Ciencias del Hombre.

Sánchez, S. (Dir.) (1988). Diccionario de Ciencias de la Educación. Madrid; Santillana.

Sarah E. Aylett (2010) People with Epilepsy and Cerebral Palsy. *Journal of Pediatric Neurology & Neurosciences* Unit, Great Ormond Street Hospital.

Sarah E. Aylett (2010) People with Epilepsy and Cerebral Palsy*. Journal of Pediatric Neurology*.

Sierra Salcedo, R. A. (2008). *La estrategia pedagógica, su diseño e implementación.* . Editorial Pueblo y Educación.

Sierra Salcedo, R. A., & Caballero Delgado, E. (2009). *Selección de lecturas de metodología de la investigación educativa.* Editorial Pueblo y Educación.

Tárraga Mínguez, R. (2005) *Adaptaciones de acceso al currículum en un alumno de educación infantil con parálisis cerebral*.

Valles, G. (2006). *El análisis polisistémico aplicado al diagnóstico del trastorno articulatorio.* Retrieved 25 de septiembre from http://www.espaciologopédico.com/artículos

Vigotsky, L. S. (1982). *Pensamiento y lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Vigotsky, L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. Editorial Científico Técnica.

ANEXO #1

Observación a participantes:

Objetivo: Constatar el nivel de orientación familiar que poseen los padre para estimular la motricidad articulatoria en sus hijos.

1. Características de la disartria que poseen sus hijos.

2. Aplicación de la puesta en práctica de las orientaciones brindadas para la corrección de la motricidad articulatoria de sus hijos.

3. Motivación al evaluar el progreso de su hijo en el desarrollo de las actividades.

ANEXO # 2

Entrevistas individuales (maestros y logopedas)

Entrevista a maestros:

Indicadores a medir

Conocimiento de la presencia de educandos con disartria.

Causas que la provocan.

Actividades que se desarrollan en el contexto escolar.

Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas. Da respuesta a cada una de ellas, y en el caso que corresponda marque con una cruz (x) en la raya que esta a la derecha.

1. ¿Eres licenciado?

Sí_____ No_____

Educación Preescolar__ Maestro Primario___ Educación Especial___

2. ¿Cuáles son las mayores dificultades en la psicomotricidad, que se aprecian en los educandos con disartria que atiendes?

¿Qué causas las originan?

3. ¿Qué preparación posees para enfrentar el trabajo dirigido a desarrollar la psicomotricidad en los educandos con disartria que atiendes?

Entrevista a logopedas

Indicadores a medir

 Conocimiento de la intervención logopedia para la estimulación de la psicomotricidad en educandos con disartria.

 Tratamiento a la psicomotricidad a través de la familia

 Actividades que se desarrollan en el contexto familiar Estamos realizando una investigación con el objetivo de conocer cómo influye la estrategia de intervención logopedia dentro de la familia en la estimulación de la psicomotricidad, con énfasis en el

trabajo preventivo de la disartria. Para lograr su cumplimiento solicitamos que se responda con sinceridad las siguientes preguntas lo cual resultara de gran apoyo para el éxito de la enseñanza.

1. ¿Cuántos años de experiencia posee como logopeda? _____

2. ¿Atiende educandos con disartria? Sí _____ No_____

De ser positiva, con qué sistematicidad?

Mensual_____ Quincenal_____ Semanal_____ Diario_____

3. ¿Por cuáles orientaciones rige su trabajo?

4. ¿Cómo consideras la intervención de la familia en las actividades de programa destinado a estos educandos?

5. ¿Cómo consideras la preparación de la familia para enfrentar la prevención o corrección de las psicomotricidad en educandos con disartria?

ANEXO # 3

Entrevista Grupal: (A las familias)

Objetivo: Obtener información sobre el conocimiento que tienen las familias sobre cómo desarrollar la motricidad articulatoria en sus hijos.

Preguntas:

¿Conoce usted cómo puede estimular la motricidad articulatoria de su hijo?

¿Usted permite que su hijo realice alguna actividad física o del hogar por si solo o en compañía de un adulto?

¿Siente usted algún tipo de lastima o pena por la patología verbal que presenta su hijo?

¿Considera usted que puede ser necesario un Libro Electrónico que oriente a la familia y a la comunidad como pueden desarrollar el lenguaje en sus hijos

ANEXO #4.

Prueba Proyectiva:

La llegada de un hijo suele ser un hecho familiar muy feliz, así la familia se carga de ilusiones y fantasías en cuanto a que nombre elegirán, a que cuido lo llevaran o a quien se parecerá, entre otros.

Veamos a continuación que le sucedió a la familia de Pedro:

Resulta que Ana la esposa de Pedro nunca había quedado embarazada y ya con casi 30 años y luego de visitar en varias sesiones la consulta de fertilidad de su área de salud y bajo tratamiento médico, logra entrar en el proceso gestacional más importante para un ser vivo.

Las ideas y los planes fueron muchos a diario se preguntaban:

¿Será niño o niña?

¿A quién se parecerá más?

¿Qué nombre le pondremos?

Todo era felicidad y armonía, pero nunca imaginaron que Ana sería la madre de una niña con disartria.

¡Si disartria! Esa logopatía verbal que pocas familias quieren tener en su seno familiar.

Luego de la tanta espera por dar a luz a un integrante a la familia que parecía ponerse feliz y al paso de un año de este suceso. La pequeña Sofía debía de comenzar a dar sus primeros pasos, pero sus padres nunca se ocuparon por la parálisis cerebral con que había nacido ni por la distrofia muscular que presentaba, solo decían que con el paso del tiempo la niña iba a ser una niña normal como la habían soñado desde que se casaron.

Por mucho que su médico de la familia, la psicopedagoga y la logopeda de la comunidad lo visitaron y le aconsejaron comenzar con estudios y tratamientos para esta patología no lo hicieron. Seguían convencidos de que todo se resolvería antes de que la niña cumpliera un año.

Ya la niña comienza a decir sus primeras palabras, aunque su vos es nasal, áspera y forzada, presenta serias dificultades para mover la lengua y los músculos faciales, en ocasiones resulta difícil comprender lo que dice ya que lo expresa con un ritmo rápido y lo hace arrastrando las palabras.

Así comienza a ser la comunicación de la pequeña Sofía, sus padres hoy están arrepentidos del tiempo perdido por no ver atendido con tiempo esta logopatía verbal.

¿Creen ustedes que la posición asumida por los padres al principio fue la correcta?

¿Hicieron ustedes lo mismo?

¿Qué orientaciones recibieron ustedes del logopeda y del médico de la familia?

¿Qué actividades se podrían ir realizando con la niña antes de que comenzara a decir sus primeras palabras?

¿Será importante esta intervención temprana por parte de la familia y de los especialistas pertinentes para tratar este trastorno del lenguaje?